Tabela 15.2. cd.

MIEJSCE BADANIA	ZASADY I SPOSÓB BADANIA
Skóra, owłosienie i paznokcie	• Zwróć uwagę na fizjologiczne zmiany w procesie starzenia • Poszukaj plamistych zmian barwnikowych, podbiegnięć krwawych i zmian wywołanych ekspozycją na promieniowanie słoneczne • Obejrzyj skórę podudzi w poszukiwaniu owrzodzeń • U starszych przewlekle leżących pacjentów poszukaj odparzeń i odleżyn • Zwróć uwagę na wszelkie bolesne zmiany pęcherzykowe rozmieszczone w obrębie dermatomu • Oceń owłosienie i paznokcie
Głowa i szyja	• Oceń powieki, oczodół kostny i gałkę oczną – ze względu na zaniki tkanki tłuszczowej oko może się wydawać wpadnięte • Zwróć uwagę na starcze opadanie powiek • Zbadaj dolne powieki, szukając wywinięcia lub podwinięcia • Zwróć uwagę na zażółcenie twardówki i obwódkę starczą rogówki • Zbadaj ostrość wzroku, używając tablic Snellena – zwróć uwagę na starczowzroczność • Źrenice powinny reagować na światło • Ruchy mięśni zewnątrzgałkowych, z wyjątkiem możliwego upośledzenia spojrzenia w górę, powinny być zachowane • Używając oftalmoskopu, zbadaj soczewki, poszukując zmętnień, i dno oka; z wiekiem dno oka traci blask i refleksy świetlne, tętnice stają się węższe, bardziej blade, proste i mniej połyskliwe

- Z wiekiem skóra staje się pomarszczona, luźna, traci napięcie (zmniejsza się grubość skóry właściwej i liczba naczyń w jej obrębie, następuje zwyrodnienie włókien elastycznych, dochodzi do spłaszczenia połączenia skórno-naskórkowego)
- Zmiany w unaczynieniu skóry sprawiają, że ta o jasnym zabarwieniu wydaje się bledsza, bardziej matowa (następuje zmiana wielkości, kształtu i zdolności barwienia się keratynocytów, spada liczba melanocytów); skóra na grzbiecie dłoni i przedramionach wydaje się przezroczysta, delikatna, cienka i luźna
- Paznokcie tracą połysk i mogą żółknąć oraz ulegać pogrubieniu; dotyczy to szczególnie paznokci u stóp
- Owłosienie głowy traci pigment, co prowadzi do siwienia; siwienie włosów pachowych jest uznawane za jeden z najbardziej wiarygodnych objawów starzenia
- Dochodzi do zmniejszenia liczby mieszków włosowych w skórze głowy
- Zmniejszeniu ulega szybkość wzrostu włosów głowy, łonowych oraz pachowych, natomiast u starszych kobiet (prawdopodobnie w związku ze zmianami hormonalnymi) czasami dochodzi do nasilenia wzrostu włosów na twarzy, a u mężczyzn nasila się wzrost brwi oraz włosów w nosie i uszach

Wzrok

- Dochodzi do zaniku tkanek otaczających oko oraz zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej w jego okolicy. Może to powodować opadanie powieki górnej oraz podwijanie powieki dolnej do wewnątrz lub na zewnątrz
- Zmniejszona produkcja łez wraz z zanikiem tkanek otaczających oko zwiększają ryzyko zakażeń oka
- Tęczówka staje się sztywniejsza, źrenica – mniejsza; pojawiają się zmiany wokół soczewki, co predysponuje osobę w wieku podeszłym do rozwoju jaskry
- Pojawia się szarobiały pierścień cholesterolu i złogów soli wapnia wokół tęczówki – obwódka starcza (gerontoxon, *arcus senilis*)
- Najczęstsze zaburzenie widzenia związane z wiekiem jest określane jako **starczowzroczność** (*presbyopia*). Polega ono na trudności ze zogniskowaniem wzroku na przedmiotach położonych blisko osoby patrzącej na nie
- Wraz z upływem lat ludzie wolniej adaptują się do nagłych zmian oświetlenia, zwłaszcza z jasnego na ciemne. Zmiany te tak dobrze korelują z wiekiem, że na ich podstawie można go określić u pacjenta z dokładnością do 3 lat
- Dochodzi do pogorszenia rozróżniania barw (oko starsze spostrzega kolor niebieski jako zielononiebieski), kontrastu, do zawężenia pola widzenia

Tabela 15.2. cd.

MIEJSCE BADANIA	ZASADY I SPOSÓB BADANIA
	• Oceń słuch • Zbadaj przewody słuchowe, szukając woskowiny, gdyż jej usunięcie może szybko poprawić słuch • Zbadaj jamę ustną, zwracając uwagę na nieprzyjemny zapach, wygląd śluzówki dziąseł, próchnicę, ruchomość zębów i ilość śliny • Poproś pacjenta o wyjęcie protez zębowych, aby zbadać dziąsła w poszukiwaniu owrzodzeń • W sposób standardowy zbadaj gruczoł tarczowy i węzły chłonne

Słuch

- Zanika kanał słuchowy zewnętrzny, co powoduje ścieńczenie ścian i zmniejszenie produkcji woskowiny
- Błona bębenkowa ulega pogrubieniu, często też staje się matowa i biała
- Z wiekiem dochodzi do pogorszenia słyszenia tonów czystych – tzw. starczego przytępienia słuchu (*presbycusis*). Bardziej upośledzone jest też słyszenie dźwięków o wyższej częstotliwości (zaburzenie to ma nieco łagodniejszy charakter u kobiet niż u mężczyzn)
- Stopniowo następuje utrata słuchu w zakresie dźwięków o średnich i niskich częstotliwościach
- Pogorszenie słyszenia związane z wiekiem dotyczy nie tylko progu słyszenia tonów o różnej częstotliwości, lecz także progu ich różnicowania – punktu, w którym wykrywalna jest różnica wysokości tonu, co powoduje zaburzenia w rozumieniu mowy. Umiejętność rozumienia mowy pogarsza się o mniej niż 5% od 6. do 59. roku życia, później zaś ulega znacznemu pogorszeniu, zmniejszając się po 80. roku życia o ponad 25% w stosunku do poziomu szczytowego. W przypadku ciągłego hałasu lub nieprzerwanej mowy osoby starsze słyszą jeszcze gorzej

Smak

- Dane dotyczące wrażliwości na smak są niespójne – różnice stwierdzono zarówno pomiędzy poszczególnymi osobami, jak i testowanymi substancjami
- Z wiekiem ulega zanikowi język oraz zmniejsza się produkcja śliny, co może powodować gorsze odczuwanie smaku
- Liczba kubków smakowych pozostaje niezmieniona, a ich wrażliwość się nie pogarsza
- Związane z wiekiem zmiany w obrębie dziąseł i zębów niekoniecznie prowadzą do pojawienia się braków w uzębieniu; ważniejszą niż wiek przyczyną utraty zębów jest zły poziom higieny jamy ustnej. Zazwyczaj ubytki zębów są konsekwencją próchnicy lub choroby dziąseł. Z wiekiem zmianie ulega lokalizacja ognisk próchnicowych, gdyż częściej stwierdza się próchnicę korzeni oraz okolic zmian poprzednio leczonych stomatologicznie
- Utrata zębów prowadzi do zmian w diecie i zwiększa ryzyko niedożywienia

Węch

- Zmysł węchu ulega nagłemu pogorszeniu po 50. roku życia. W tym okresie dochodzi także do istotnego zwyrodnienia obszarów mózgu uczestniczących w odczuwaniu zapachów. W wieku 80 lat węch jest prawie o 50% gorszy niż w okresie maksymalnych możliwości
- Zmysły smaku i węchu są razem zaangażowane w rozróżnianie smaków. Z wiekiem mogą wystąpić problemy z rozpoznawaniem produktów rozdrobnionych na podstawie ich smaku i zapachu

Dotyk

- Wraz z wiekiem odpowiedź na bodźce bólowe się pogarsza
- Wrażliwość rogówki na lekki dotyk zmniejsza się po 50. roku życia

Tabela 15.2. cd.

MIEJSCE BADANIA	ZASADY I SPOSÓB BADANIA
Klatka piersiowa i płuca	• Przeprowadź typowe badanie, pamiętając, że zlokalizowane trzeszczenia czasami mają niepewne znaczenie diagnostyczne i nie zawsze są objawem ostrej choroby • Zawsze powinno się wykluczyć nową chorobę układu oddechowego
Układ sercowo-naczyniowy	• Przypomnij sobie wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna • Zbadaj tętno na tętnicach szyjnych, wyczuwając palpacyjnie wyrzut krwi do tętnic szyjnych, i osłuchaj tętnice w poszukiwaniu szmerów • Oceń uderzenie koniuszkowe • Osłuchaj serce, skupiając się na tonach S_1 i S_2; zwróć uwagę na obecność tonów S_3 i S_4 oraz szmerów w każdym osłuchiwanym obszarze
Gruczoły piersiowe i pachy	• Obejrzyj i zbadaj palpacyjnie piersi, poszukując zmian i guzów • Pamiętaj o zbadaniu ogona Spence'a, który rozciąga się aż do pachy • Zbadaj pachy, poszukując powiększonych węzłów chłonnych

- Zwiększają się rozmiary tchawicy i dużych oskrzeli
- Poszerzenie końcowych odcinków dróg oddechowych powoduje zmniejszenie pola powierzchni pęcherzyków płucnych
- Masa płuc się zmniejsza, a objętość zalegająca zwiększa
- Maksymalna prędkość nasilonego wydechu stopniowo się zmniejsza i kaszel staje się mniej efektywny [zmniejszenie natężonej pojemności życiowej (FVC) o około 21 ml/rok oraz natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV_1) o około 24 ml/rok]
- Zmniejszona elastyczność pęcherzyków płucnych powoduje rozdęcie płuc i obniżenie przepony
- Końcowe odcinki żeber wapnieją w miejscu połączenia z mostkiem, co powoduje usztywnienie klatki piersiowej, a tym samym zwiększenie wysiłku mięśni oddechowych
- Zmiany układu kostnego związane z wiekiem i osteoporotyczne złamania trzonów kręgów mogą nasilać kifozę kręgosłupa piersiowego, zwiększając wymiar przednio-tylny klatki piersiowej; powstaje klatka beczkowata, co ma niewielkie znaczenie funkcjonalne

- Z wiekiem istnieje tendencja do ujawniania się chorób mięśnia sercowego, zastawek serca oraz tętnic wieńcowych
- Dochodzi do zmian w naczyniach krwionośnych. Komórki je wyściełające stają się zróżnicowane w zakresie wielkości i kształtu. Pogrubieniu ulega też tkanka łączna pokrywająca naczynia
- Duże tętnice ulegają wydłużeniu i pogrubieniu. Wydłużenie i kręty przebieg aorty oraz jej gałęzi sporadycznie prowadzą do zagięcia tętnicy szyjnej w dolnej części szyi, zwłaszcza po stronie prawej. Powstająca w ten sposób tętniąca zmiana, pojawiająca się głównie u kobiet z nadciśnieniem, może zostać pomylona z tętniakiem tętnicy szyjnej. Kręty przebieg aorty czasami prowadzi do podwyższonego ciśnienia w żyłach szyjnych po stronie lewej, poprzez utrudnienie odpływu w klatce piersiowej
- Dodatkowe tony serca – S_3 i S_4:
  - po 40. roku życia utrzymujący się 3. ton serca mocno sugeruje zastoinową niewydolność serca wynikającą z objętościowego przeciążenia lewej komory, jak ma to miejsce w chorobie niedokrwiennej serca lub wadach zastawkowych
  - S_4 może być słyszalny u zdrowych osób starszych, ale często sugeruje zmniejszoną podatność komór i upośledzenie ich napełniania
- Skurczowy szmer aortalny występuje u ⅓ osób w wieku około 60 lat i u ponad połowy osób w wieku 85 lat. U większości osób proces włóknienia i wapnienia – zwany jako **stwardnienie zastawki aortalnej** – nie upośledza przepływu krwi. U niektórych dochodzi do zwapnienia i unieruchomienia płatków zastawki aortalnej, co prowadzi do powstania **stenozy aortalnej** i zwężenia drogi odpływu. Podobne zmiany następują w zastawce mitralnej, zwykle około dekady później niż stwardnienie zastawki aortalnej
- Zróżnicowaniu ulega przepływ krwi przez różne narządy: w nerkach może się zmniejszać o 50%, a w mózgu – o 15–20%

- Z wiekiem piersi kobiet zmieniają się, co związane jest z atrofią tkanki gruczołowej i zastępowaniem jej przez tkankę tłuszczową. Pomimo że proporcjonalnie ilość tkanki tłuszczowej się zwiększa, jej bezwzględna ilość może ulec zmniejszeniu; piersi często stają się wiotkie i obwisłe
- Przewody otaczające brodawkę sutkową mogą się stać łatwiej wyczuwalne jako zwarte postronki
- Owłosienie pachowe zanika

Tabela 15.2. cd.

MIEJSCE BADANIA	ZASADY I SPOSÓB BADANIA
Jama brzuszna	• Przeprowadź standardowe badanie jamy brzusznej • Sprawdź, czy nie występują szmery nad aortą, tętnicami nerkowymi i udowymi • Zbadaj nadbrzusze, szukając tętnienia aorty. Oceń szerokość aorty, stosując głębszy ucisk rękami, po obu jej stronach
Obwodowy układ naczyniowy	• Uważnie zbadaj tętno
Żeńskie narządy płciowe	• Pomóż starszej kobiecie przyjąć odpowiednią pozycję • Zbadaj srom, szukając zmian związanych z menopauzą, takich jak ścieńczenie skóry, utrata owłosienia łonowego oraz zmniejszenie elastyczności przedsionka pochwy • Zwróć uwagę, czy nie występuje rumień w obrębie sromu • Zbadaj cewkę moczową, poszukując jej mięska, czyli wypadania mięsistej, zaczerwienionej śluzówki przy ujściu cewki moczowej • Zwróć uwagę na ewentualne powiększenie łechtaczki • Rozsuń wargi sromowe i wprowadź wziernik: zbadaj ściany pochwy, które mogą wykazywać cechy zaniku, oraz szyjkę macicy • W razie potrzeby pobierz wymaz • Po usunięciu wziernika poproś pacjentkę o napięcie tłoczni brzusznej w celu wykrycia wypadania macicy, pęcherza moczowego, cewki moczowej lub odbytnicy • Przeprowadź badanie dwuręczne, sprawdź ruchomość szyjki macicy oraz obecność nieprawidłowych oporów w macicy lub przydatkach • Przeprowadź jednoczesne badanie odbytnicy i pochwy

- Przewód pokarmowy (jako całość) wykazuje mniej zmian czynnościowych niż inne układy
- Zaburzenia połykania występują częściej u osób, które nie mają zębów. U osób starszych połykanie zajmuje od 50 do 100% więcej czasu niż u osób młodych
- Zmiany motoryki przełyku związane ze starzeniem określa się jako *presbyesophagus*; podstawowym zaburzeniem jest zmniejszenie amplitudy skurczów perystaltycznych przełyku
- Gdy dochodzi do związanego z wiekiem zaniku komórek okładzinowych żołądka, zmniejszeniu ulega wydzielanie kwasu solnego, czego objawem jest **achlorchydria** (bezkwaśność)
- Z uwagi na spowolnienie transportu treści jelitowej w jelicie grubym u osób starszych często występują zaparcia
- Zwiększa się liczba receptorów dla substancji opioidowych, co może prowadzić do istotnych zaparć podczas stosowania leków narkotycznych
- Od wieku średniego istnieje tendencja do odkładania tkanki tłuszczowej w okolicy dolnej części jamy brzusznej i w okolicach bioder, nawet jeśli masa ciała się nie zmienia. To nagromadzenie tkanki tłuszczowej w połączeniu z osłabieniem mięśni brzucha często prowadzi do powstania miękkiego, wystającego brzucha
- W procesie starzenia może dojść do osłabienia objawów ostrego brzucha. Ból może mieć mniejsze nasilenie, gorączka jest często słabiej wyrażona, a objawy otrzewnowe, takie jak obrona mięśniowa czy dodatni objaw Blumberga, bywają osłabione lub nawet nieobecne
- Z upływem czasu rozmiary wątroby się zmniejszają. Jej kształt dostosowuje się do zarysów narządów sąsiednich

- W procesie starzenia dochodzi do względnie niewielu istotnych klinicznie zmian w naczyniach obwodowych. Istnieje tendencja do wydłużania i krętego przebiegu tętnic obwodowych, które stają się bardziej twarde i mniej sprężyste
- Osłabione lub nieobecne tętno może wskazywać na niedrożność naczyń – rozważ oznaczenie wskaźnika kostkowo-ramiennego

- Czynność jajników zwykle zaczyna wygasać w 5. dekadzie życia. Krwawienia miesięczne zanikają średnio między 45. a 52. rokiem życia. Wraz z obniżeniem stymulacji estrogenowej wiele kobiet odczuwa uderzenia gorąca – dolegliwości te utrzymują się do 5 lat
- Często występują zaburzenia snu i zmiany nastroju
- Kobiety mogą odczuwać suchość pochwy, parcie naglące lub dysparenurię. Zmniejsza się wydzielanie śluzu, co sprzyja infekcjom i występowaniu świądu
- Owłosienie łonowe się zmniejsza i siwieje, wargi sromowe i łechtaczka maleją
- Pochwa się skraca i zwęża, a jej śluzówka staje się cienka, blada i sucha
- Macica i jajniki maleją. Po 10 latach od menopauzy jajniki zwykle nie są wyczuwalne
- Seksualność i popęd często pozostają niezmienione
- Funkcje zwieraczy ulegają osłabieniu; występuje nietrzymanie moczu

Tabela 15.2. cd.

MIEJSCE BADANIA	ZASADY I SPOSÓB BADANIA
Męskie narządy płciowe i gruczoł krokowy	• Zbadaj prącie, odsuwając napletek • Zbadaj mosznę, jądra i najądrza • Przeprowadź badanie per rectum, zwracając uwagę na każdy nieprawidłowy opór w odbytnicy i wszelkie guzki lub zmiany w gruczole krokowym
Układ mięśniowo-szkieletowy	• Pacjenci, u których wywiad i badanie lekarskie wskazują na możliwość zwiększonego ryzyka upadków, powinni zostać poddani szczegółowym badaniom • W przypadku osób, u których wystąpił co najmniej jeden upadek, należy zebrać wywiad dotyczący okoliczności wystąpienia upadku, przeprowadzić badanie lekarskie, EKG oraz wstępną ocenę równowagi i chodu. Powinna ona obejmować test „wstań i idź” • Jeśli stwierdza się deformacje stawów, upośledzenie ruchomości lub ból podczas poruszania, należy przeprowadzić dokładniejsze badanie poszczególnych stawów
Układ nerwowy	• Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek deficyty, przeprowadź dokładne badanie • Skoncentruj się na zaburzeniach pamięci i afektu • W przypadku zaburzeń świadomości ustal, czy: – objawy są odwracalne, czego przykładem może być delirium – stan przejściowy wynikający z naruszenia homeostazy mózgu, która zachodzi w sytuacjach szczególnych, takich jak: gorączka, odwodnienie, zakażenie, podwyższona liczba cytokin – jest to stan nieodwracalny – przy wielofunkcyjnej niewydolności mózgu dochodzi do trwałego jego uszkodzenia w różnych obszarach, co objawia się zaburzeniem funkcji poznawczych, depresją i spowolnieniem ruchowym • Zwróć uwagę na równowagę, zwłaszcza w pozycji stojącej • Poproś pacjenta o przejście 2,5 m na czas, oceń cechy chodu, takie jak: szerokość kroku, tempo i długość marszu oraz zmiany kierunku • Poszukaj takich objawów, jak: drżenia, sztywność, bradykinezja, mikrografia, chód szurający

WYNIKI BADANIA
• Wielkość prącia maleje, a położenie jąder w mosznie ulega obniżeniu • Owłosienie łonowe się zmniejsza i siwieje • Zaburzenia erekcji lub niemożność uzyskania wzwodu dotyczą około 50% starszych mężczyzn • Rozrost powoduje powiększanie objętości gruczołu krokowego do 7. dekady życia, następnie przechodzi w fazę plateau. Zmiany te są zależne od androgenów • Oddawanie moczu słabym strumieniem i niecałkowite opróżnianie pęcherza często mogą mieć inne przyczyny niż łagodny rozrost gruczołu krokowego (benign prostatic hyperplasia – BPH)
• W miarę starzenia zmniejsza się masa i siła mięśni szkieletowych, a więzadła tracą swą rozciągliwość • Zmniejsza się zakres ruchów • Wzrost kości ulega spowolnieniu, stają się one cieńsze i bardziej porowate. Pionową podporę traci wewnętrzna struktura kości, co istotnie wpływa na jej wytrzymałość • Czaszka z wiekiem staje się grubsza. Zwiększeniu ulegają wszystkie jej wymiary – szczególnie dotyczy to części głębokich oraz zatok czołowych
• Zmiany strukturalne i biochemiczne mózgu związane z wiekiem nie muszą upośledzać myślenia i zachowania • Nie ulegają upośledzeniu podstawowe umiejętności językowe oraz zdolność utrzymywania nieprzerwanej uwagi, natomiast zmieniają się pewne aspekty możliwości poznawczych – najwcześniej możliwość przyswojenia dużej ilości informacji, które trzeba dłużej pamiętać • Późno ulega upośledzeniu umiejętność nazywania zadań i pojęć abstrakcyjnych • Osoby starsze często częściowo lub całkowicie tracą czucie wibracji w obrębie stóp i kostek (ale nie w okolicy palców czy goleni). Rzadziej pogarsza się lub zanika czucie położenia • Odruch wymiotny i odruchy brzuszne mogą być osłabione lub zanikać • Odruchy skokowe mogą być symetrycznie osłabione lub nieobecne. Rzadziej podobnie zmienione są odruchy kolanowe • Częściowo z powodu zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym stóp, odruchy podeszwowe mogą być mniej wyraźne i trudniejsze w interpretacji • Otępienie – podział: – zmiany zwyrodnieniowe typu alzheimerowskiego (60–70% przypadków) – otępienie typu naczyniowego (10–20% przypadków) – z innych przyczyn (m.in. otępienie z ciałami Lewy'ego, otępienie czołowo-skroniowe, choroba Parkinsona) (5–10% przypadków) – otępienie typu mieszanego (szczególnie typu alzheimerowskiego i naczyniowego) – depresja – majaczenie (delirium)

Zwiększająca się z wiekiem indywidualność biologiczna ludzi starszych oraz odmienność ich potrzeb doprowadziła do wypracowania wielu testów badających przekrojowo poszczególne obszary **życia. Standaryzacja** tych testów pozwala na wprowadzenie kanonu diagnostycznego i obiektywizację wyników w populacji pacjentów geriatrycznych. Narzędziem o uznanej wartości dla określenia problemów geriatrycznych jest całościowa ocena geriatryczna (COG, comprehensive geriatric assessment), dzięki której można dokładniej diagnozować doraźne problemy zdrowotne chorego, a także planować postępowanie w trakcie hospitalizacji i po wypisie ze szpitala. Podejście oparte na konkretnym problemie pozwala zintegrować informacje i ustalić jasny, indywidualnie dobrany plan działania.

PIŚMIENNICTWO

1. Bickley L.S.: *Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym* (wyd. polskie pod red. Z. Gacionga i P. Jędrusika). Termedia, Poznań 2010.
2. Dauglas G., Nicol F., Robertson C. (red.): *Macleod. Badanie kliniczne.* Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
3. Kostka T., Kozierska-Rościszewska M.: *Choroby wieku podeszłego*. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
4. Rosenthal T., Naughton B., Williams M. (red.): *Geriatria* (wyd. polskie pod red. L. Pączka, M. Niemczyka). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009.
5. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): *Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne*. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

16. OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO

Danuta Zarzycka

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi [*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069); *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej* (Dz.U. z 2018 r., poz. 941)] **dokumentacja medyczna** może być prowadzona w **formie papierowej** lub **elektronicznej** przez osoby świadczące usługi zdrowotne, w tym pielęgniarki i/lub położne.

Zakres treści zapisu w dokumentacji uzależniony jest od miejsca i charakteru wykonywania świadczeń zdrowotnych. W dokumentacji osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych może się znajdować m.in. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karta wizyty patronażowej czy karta przebiegu ciąży, książeczka zdrowia dziecka. Natomiast wśród dokumentacji szpitalnej można wskazać na historię choroby, do której dołączona jest karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karta obserwacji porodu czy karta gorączkowa, oraz księgę raportów pielęgniarskich. Treść zapisu zawarta w dokumentacji pielęgniarskiej według *Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej* (Dz.U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039; Dz.U. z 2019 r., poz. 576, 577, 1490 i 1590) powinna obejmować informacje dotyczące rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta oraz jego problemów pielęgnacyjnych, planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad chorym; samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych i edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia. Dokumentowanie zatem jest to zespół czynności, które pielęgniarka/ /położna wykonuje codziennie, wielokrotnie, a produkt finalny procesu jest dokumentem w sprawie realizacji świadczenia opieki na podstawie rozpoznania stanu pacjenta.

Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych zasad dokumentowania sytuacji zdrowotnej pacjenta według schematu **SOAP** (IER) (**S**ubjective, **O**bjective, **A**ssessment, **P**lan) oraz procesów towarzyszących przejściu od danych o sytuacji zdrowotnej pacjenta do formułowania diagnoz pielęgniarskich i planowania, realizowania, jak też oceniania opieki.

16.1. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW BADANIA PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO

16.1.1. ZASADY DOKUMENTOWANIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych oraz w podręczniku pielęgniarskim sformułowano podstawowe zasady dokumentowania sytuacji zdrowotnej pacjenta przez pracownika opieki zdrowotnej.

- Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.
- Każdy wpis w dokumentacji jest oznaczony danymi osoby, która go dokonała.
- Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli jest błędny, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i dane osoby dokonującej tej adnotacji.
- Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość. W razie sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej strony wydruku są numerowane.
- W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej pierwsza strona dokumentacji indywidualnej zawiera oznaczenie pacjenta, a kolejne strony – co najmniej jego imię i nazwisko.
- Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości pacjenta, w dokumentacji dokonuje się oznaczenia go jako „NN", z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.
- Do dokumentacji indywidualnej włącza się dokumentację udostępnioną przez pacjenta lub odnotowuje się zawarte w niej informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.
- Dokument włączony do dokumentacji indywidualnej nie może być z niej usunięty.
- W dokumentacji medycznej wpisuje się nazwę i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu według aktualnie obowiązującej

wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (np. ICD-10) i/lub terminy według przyjętego nazewnictwa pielęgniarskiego, najlepiej standaryzowanego, np. klasyfikacji diagnoz (NANDA-I), klasyfikacji wyników opieki (NOC) i klasyfikacji interwencji (NIC).

- Do organizacji zapisu treści zaleca się wykorzystywanie schematów i towarzyszących im skrótów nomotetycznych – w tym opracowaniu omówiono ramy SOAP (subiektywne informacje/obiektywne informacje/ocena i diagnoza/plan opieki), które powinny pomóc w uporządkowaniu informacji w krótkiej i klarownej formule.
- W dokumentacji indywidualnej zamieszcza się lub do dokumentacji dołącza się:
  - oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz danych umożliwiających kontakt z upoważnioną osobą,
  - oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
  - oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
  - informację o tym, że pacjent nie złożył wyżej wymienionych oświadczeń.
- Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym pod warunkiem:
  - zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem lub utratą,
  - integralności treści dokumentacji i metadanych polegającej na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian,
  - stałego dostępu do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
  - identyfikacji osoby dokonującej wpisu oraz udzielającej świadczeń zdrowotnych,
  - jej udostępnienia, w tym przez eksport w postaci elektronicznej,
  - funkcjonalności i estetyki wydruku dokumentacji.

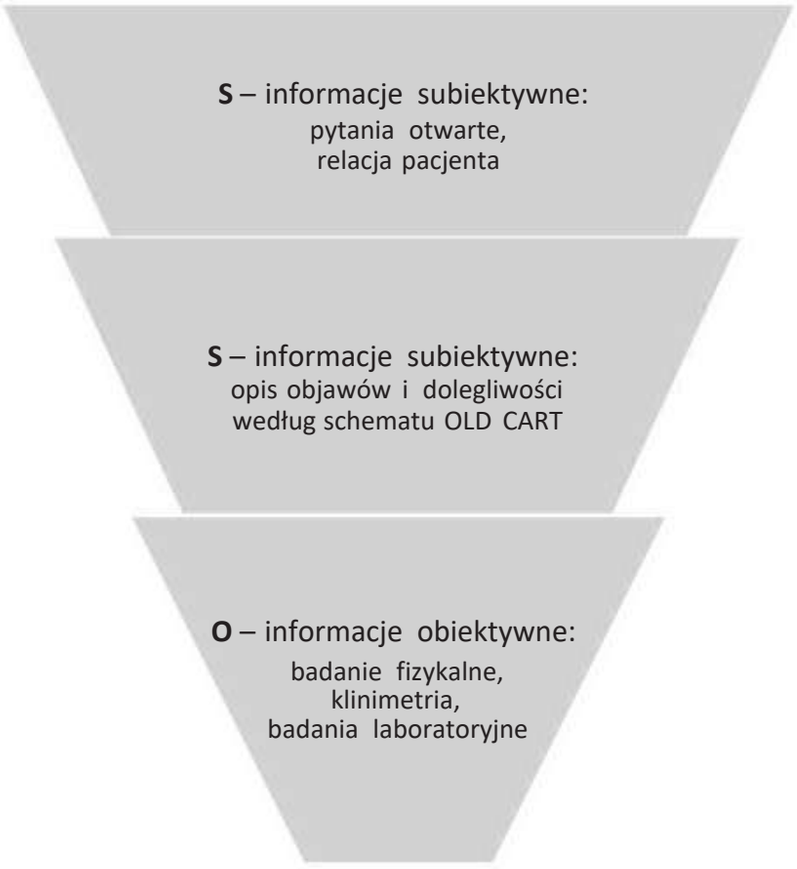
16.1.2. SCHEMAT OPISU STANU ZDROWIA PACJENTA – SOAP

Akronim SOAP pochodzi od nazw etapów struktury opisu sytuacji zdrowotnej pacjenta w języku angielskim:

- **S**ubjective – informacje subiektywne: doświadczenia, osobiste poglądy czy uczucia pacjenta (w tym ból) lub kogoś bliskiego, główna skarga/problem

pacjenta (chief complaint – CC), historia obecnej choroby (history of the present illness – HPI), przeszłość chorobowa pacjenta (past medical history – PMH), poglądy pacjenta dotyczące funkcjonowania układów anatomiczno-fizjologicznych (review of systems – ROS).

- **O**bjective – informacje obiektywne: 5 objawów podstawowych (tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura, ból oceniany z wykorzystaniem skal), wyniki badania fizykalnego, badań laboratoryjnych i obrazowych, dokumentacja historii leczenia, wartości ocen klinimetrycznych (ryc. 16.1).
- **A**ssessment – ocenianie kompletności informacji i formułowanie diagnozy poprzez syntezę informacji subiektywnych i dowodów obiektywnych, aby wyciągając z nich wnioski, sformułować diagnozy. Jest to ocena stanu pacjenta poprzez analizę problemu, możliwość interakcji z innymi problemami/ /objawami oraz zmiany w statusie problemów.
- **P**lan – plan opieki z hierarchicznie uporządkowanymi działaniami.



Rycina 16.1. *Schemat gromadzenia zakresu informacji subiektywnych i obiektywnych o stanie zdrowia pacjenta.*

Struktura **SOAP** została opracowana w II połowie XX wieku przez dr. Lawrence'a Weeda. Początkowo poznawcze ramy oceny informacji były wykorzystywane przez lekarzy w celu umożliwienia im podejścia w wysoce zorganizowany sposób do złożonych problemów pacjentów. Obecnie jest powszechnie stosowana jako narzędzie komunikacji między interdyscyplinarnymi świadczeniodawcami i jako sposób dokumentowania stanu pacjenta [11]. Zaletą tej zwartej struktury porządkowania istotnych informacji o pacjencie jest koncentrowanie uwagi pracowników medycznych na ograniczaniu informacji do tych najbardziej użytecznych, co w powszechnym dążeniu do dokumentacji elektronicznej i pokusie jej rozszerzania wydaje się skutecznie zapobiegać sytuacji nadmiaru wiadomości, których pracownicy medyczni nie będą w stanie przeczytać i opanować.

Jednym z istotniejszych ograniczeń SOAP jest niemożność udokumentowania zmian w czasie. Dlatego zaproponowano rozszerzenie SOAP, którym są **SOAPIE** i **SOAPIER**. Schemat SOAPIE dodatkowo uwzględnia wdrożenie interwencji (**I**mplementation) i ich ewaluację (**E**valuation), natomiast formuła poznawcza SOAPIER została wzbogacona o rewizję postępowania (**R**eview). Udoskonalenia schematu SOAP są znaczące dla zwiększenia skuteczności komunikacji pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego, w tym pielęgniarkami i lekarzami, trafności decyzji diagnostycznych oraz jakości i bezpieczeństwa świadczonej opieki [3].

W literaturze istnieją opisy innych modeli poznawczych przedstawiających kroki, które mogą pomóc początkującym i doświadczonym pracownikom medycznym w utrzymaniu świadomości sytuacyjnej i uczeniu się w szybko zmieniających się środowiskach klinicznych. Jednym z takich modeli jest **OODA**, który został opracowany przez Johna Boyda, aby pomóc w organizacji celowego myślenia i działania. Obejmuje następujące etapy: obserwuj (**O**bserve), orientuj się (**O**rient), decyduj (**D**ecide), działaj (**A**ct) [14]. OODA to model decyzyjny zorientowany na działanie, który jest powtarzalny. Zakończenie jednego cyklu podpowiada następny. Nie ma ustalonych przedziałów czasowych dla cykli OODA – czas ich trwania zależy od tego, jak szybko zmieniają się okoliczności. Celem pętli OODA jest myślenie i działanie szybciej i lepiej, a tym samym maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Opis objawów i dolegliwości w części poświęconej informacjom obiektywnym zawiera wskazanie do posługiwania się w ocenie stanu pacjenta również pomiarem pośrednim z wykorzystaniem skal i kwestionariuszy klinicznych, które pozwalają ocenić zjawiska kliniczne występujące u chorego z określoną trafnością, dokładnością, powtarzalnością oraz czułością i swoistością. Trafne i rzetelne metody pomiarowe są niezbędne zarówno w praktyce klinicznej, jak i badaniach,

szczególnie przy ocenie skuteczności postępowania terapeutycznego i pielęgniarskiego. Ramy koncepcyjne dla obiektywnego pomiaru i oceny danych klinicznych, używając licznych specyficznych metod blisko spokrewnionych ze strategią psychometrii i taksonomii, sformułował Alvan Feinstein z Yale Medical School w 1983 r., który wprowadził pojęcie **klinimetria** (clinimetrics) [9].

Z perspektywy praktyki opartej na dowodach niezbędne jest posiadanie narzędzi pomiarowych, które umożliwiają wykrycie istotnych klinicznie zmian w stanie zdrowia pacjenta wynikających z rozwoju choroby, interwencji diagnostycznych i terapeutycznych, co pozwoli na trafne – czyli o wysokiej wartości predykcyjnej – ustalenie rozpoznania.

16.1.3. WYBRANE SKALE KLINIMETRYCZNE DO OCENY STANU PACJENTA

Współcześnie w medycynie, pielęgniarstwie czy położnictwie znanych jest bardzo wiele różnorodnych skal i kwestionariuszy pozwalających na ocenę wybranych funkcji, objawów czy określonych zachowań występujących u człowieka, uwzględniających swoistość cechy istotnej dla poznania stanu zdrowia czy etapu rozwoju. Decydując się na stosowanie tego typu narzędzi, należy znać ich właściwości pomiarowe, tj. rzetelność, trafność, moc i czułość.

Rzetelność testu jest synonimem jego dokładności i niezawodności.

Trafność to cecha testu, która oznacza, że mierzy on właśnie to, co miał mierzyć zgodnie z intencjami twórców zawartymi w jego nazwie. Odzwierciedla trafność operacjonalizacji wiedzy dokonanej w procesie określania pytań/ /stwierdzeń tworzących pozycje testowe.

Moc testu to prawdopodobieństwo dokładności różnicowania cech, zjawisk jako prawdziwe lub fałszywe, np. prawdopodobieństwo dokładności diagnostycznej testu uzależnienia od nikotyny autorstwa Fagerströma (Fagerström Test for Nicotine Dependence – FTND) pozwala na wskazanie w populacji osób uzależnionych od palenia tytoniu wraz ze stopniem uzależnienia.

W diagnostyce medycznej wykorzystywane jest pojęcie czułości testu, w uproszczeniu tożsame z mocą testu. **Czułość** testu to zdolność wykrywania osób rzeczywiście chorych (posiadających daną cechę), to wskazanie procentu z nich mających pozytywny wynik testu, np. czułość 100% oznacza, że po zastosowaniu testu X wszystkie osoby chore na cukrzycę zostaną rozpoznane.

W charakterystyce narzędzi pomiarowych ważne są normy dla interpretacji uzyskanych wyników, często uwzględniające etap rozwoju człowieka, stopień zaawansowania choroby czy płeć.

OCENA STANU DZIECKA

Skala Apgar

Skala ta służy do oceny podstawowych funkcji życiowych noworodka. Nazwa jej pochodzi od nazwiska twórczyni – Virginii Apgar, amerykańskiej lekarki, która opracowała ją w latach 50. XX wieku. Badanie ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości wymagających interwencji lekarzy i prognozuje rozwój dziecka. Wykonywane jest przynajmniej dwukrotnie, w 1. i 5. minucie.

W 1. minucie, na podstawie skali Apgar, ocenia się, czy noworodek nie potrzebuje natychmiastowej pomocy. Kolejne pomiary (3., 5. i 10. minuta) pozwalają na określenie stabilności stanu funkcji życiowych dziecka. Przedmiotem badania są: kolor skóry, szybkość tętna, napięcie mięśni, reakcje na bodźce, oddychanie. Zakres wartości skali Apgar to 0–10 pkt. Noworodek, który uzyskał co najmniej 8 pkt, uważany jest za zdrowego, natomiast przy 3 pkt i mniej stan określany jest jako ciężki. Ocena dokonana w 5. minucie życia noworodka, której wartość wynosi 0–3 pkt, prognozuje śmierć dziecka dokładniej niż wartość pH w tętnicy pępowinowej.

Normy interpretacji wyniku:

8–10 pkt – stan dobry,

4–7 pkt – stan średni,

0–3 pkt – stan zły.

Ograniczenia interpretacji wyniku dotyczą stanu matki, w tym sedacji lub znieczulenia i przyjmowanych leków, oraz stanu noworodka: wrodzone wady rozwojowe, wiek ciążowy, uraz i dodatkowo zmienności ocen między obserwatorami [20]. Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics, 2015) zaleca stosowanie skali Apgar jako narzędzia zapewniającego akceptowaną i wygodną metodę zgłaszania stanu noworodka natychmiast po urodzeniu, w określonym jednym punkcie czasu oraz reakcji na resuscytację w razie potrzeby (tab. 16.1).

Tabela 16.1. Skala Apgar

	OCENA NOWORODKA WEDŁUG SKALI APGAR			
	CECHA	0 PKT	1 PKT	2 PKT
A	Appearance (skin color) **kolor skóry**	sinica całego ciała	tułów różowy, sinica części dystalnych kończyn	całe ciało różowe
P	Pulse **tętno na minutę**	niewyczuwalny	< 100	> 100
G	Grimace (reflex irritability) **reakcja na bodźce** • wprowadzenie cewnika do nosa • drażnienie podeszew stóp	brak	grymas twarzy, słabe poruszanie	kaszel lub kichanie, płacz
A	Activity (muscle tone) **napięcie mięśni**	brak napięcia, wiotkość ogólna	napięcie obniżone, zgięte kończyny	napięcie prawidłowe, samodzielne ruchy
R	Respiration **oddychanie**	brak oddechu	wolny i nieregularny	głośny płacz

Źródło: Przedpełska-Winiarczyk M., Kułak W.: *Skala Apgar obecnie*. Probl. Hig. Epidemiol., 2011, 92 (1), 25–29.

Skala FLACC

Skala FLACC (**F**ace, **L**egs, **A**ctivity, **C**ry, **C**onsolability) zapewnia proste ramy do oceny ilościowej zachowań bólowych u dzieci, które nie mogą zwerbalizować obecności lub nasilenia bólu. Została stworzona dla dzieci od 2. miesiąca do 7. roku życia [17]. Ocenia 5 zachowań towarzyszących odczuwaniu bólu: wyraz twarzy (Face), ułożenie nóg (Legs) aktywność (Activity), płacz (Cry), możliwość uspokojenia (Consolability).

Zasady przeprowadzania oceny z wykorzystaniem skali FLACC:

- obserwować przez co najmniej 2–5 minut,
- obserwować odkryte nogi i ciało oraz płacz,
- zmienić położenie pacjenta lub obserwować aktywność, ocenić ciało pod kątem ułożenia i napięcia,
- w razie potrzeby zainicjować pocieszające interwencje.

Każda kategoria jest punktowana w skali 0–2, co daje łączny wynik w przedziale 0–10.

Ocena wyniku behawioralnego:

0 pkt – zrelaksowany i brak bólu,

1–3 pkt – łagodny ból,

4–6 pkt – umiarkowany ból,

7–10 pkt – silny ból/dyskomfort [17].

Ocena natężenia dolegliwości bólowych wyznacza sposób stosowania terapii. Leki przeciwbólowe powinno się podawać, gdy pacjent otrzyma więcej niż 3 pkt z 10 możliwych. Leki nieopioidowe należy stosować w przypadku punktacji 4–6/10, a opioidy – 7–10/10.

Wytyczne postępowania w bólu proceduralnym i pooperacyjnym, wydane przez Brytyjskie Towarzystwo Anestezjologów Dziecięcych w 2012 roku, wskazują na użycie skali FLACC do oceny bólu. W przeglądzie systematycznym, którego celem była rygorystyczna ocena wiarygodności, aktualności, wykonalności i użyteczności skali FLACC dla potrzeb klinicznych i badawczych, uwzględniono 25 badań oceniających psychometrię i 52 badania kliniczne. Wyniki analizy świadczą o wiarygodności skali w ocenie bólu pooperacyjnego u niemowląt i dzieci. Właściwości psychometryczne skali: trafność, rzetelność, moc są zróżnicowane w populacjach, jednak ogólnie na poziomie akceptowalnym [6]. Dla przykładu, w ocenie bólu ostrego w stanie krytycznym dzieci wykazano istotną statystycznie korelację z wynikami natężenia bólu szacowanego innymi skalami, wskazano na reaktywność w ocenie bólu po podaniu leków przeciwbólowych, a rzetelność oceniona współczynnikiem alfa Cronbacha wyniosła 0,882 [23]. Istnieją ograniczone i sprzeczne dane dotyczące oceny bólu proceduralnego, chociaż w badaniu dzieci po zabiegu operacyjnym wykazano, że dla FLACC współczynnik alfa Cronbacha był równy 0,92. Czułość i swoistość skali wynosiły odpowiednio 94,9 i 73,5% przy wartości granicznej bólu 2. Ponadto zauważono, że okoliczności procedur zakłócały stosowanie skali [7] (tab. 16.2).

Tabela 16.2. Skala FLACC

	OCENA BÓLU WEDŁUG SKALI FLACC			
	KATEGORIA	0 PKT	1 PKT	2 PKT
F	Face **wyraz twarzy**	twarz bez szczególnego wyrazu lub uśmiechnięta	okresowe grymasy, marszczenie brwi, twarz zasmucona, niezainteresowana	częste lub stałe grymasy, drżący podbródek, zaciśnięte szczęki
L	Legs **ułożenie nóg**	swobodne, zrelaksowane	niespokojne, napięte	kopanie, wyciąganie nóg
A	Activity **aktywność**	leży spokojnie w normalnej pozycji, łatwo się porusza	wierci się, przesuwa do przodu/tyłu, napięte	wygina się, sztywnieje, szarpie się
C	Cry **płacz**	nie płacze	popłakuje, jęczy, kwili, sporadyczne skargi	płacze cały czas, łka lub krzyczy, częste skargi
C	Consolability **możliwość uspokojenia**	spokojne i zadowolone	daje się uspokoić głaskaniem, przytulaniem, mówieniem do siebie, ale niespokojne	trudno utulić i zapewnić wygodę

Źródło: Rozalska-Walaszek I., Aftyka A.: *Metody monitorowania bólu u noworodków i niemowląt*. Pielęg. XXI w., 2014, 2(47), 29–33.
Korekta za: Merkel S.I., Voepel-Lewis T., Shayevitz J.R., Malviya S.: *FLACC: a behavioral scale for scoring postoperative pain in young children*. Pediatr. Nurs., 1997, 23(3), 293–297.

OCENA STANU OSOBY DOROSŁEJ

Kwestionariusz bólu McGill

Kwestionariusz bólu McGill (McGill Pain Questionaire – MPQ) jest najczęściej stosowanym wielowymiarowym narzędziem do pomiaru jakości i intensywności bólu. Nazwa skali pochodzi od nazwy Uniwersytetu McGilla (Montreal, Quebec, Kanada), w którym pracował jej autor Ronald Melzack i jego współpracownik Warren Torgerson.

Metodyka opracowania kwestionariusza opierała się na stworzeniu listy 102 przymiotników, którymi pacjenci opisywali odczuwane dolegliwości bólowe, i wymyśleniu dla nich ram teoretyczno-statystycznych [15]. Natomiast skale oceny bólu opracowane przez innych badaczy na podstawie metodologii MPQ, w liczbie około 50, zawierają od 15 do 176 słów (określeń słownych/przymiotnikowych bólu). Polski „język bólu" autorstwa Andrzeja Szczudlika (1983 rok) zawiera 58 określeń.

W oryginale narzędzie MPQ składa się z 78 deskryptorów bólu uporządkowanych w obrębie 20 grup słów opisujących cztery aspekty bólu:

- sensoryczny (**S**, 1–10),
- afektywny (**A**, 11–15),
- oceniający (**OC**, 16),
- różnorodny (**R**, 17–20, w tym: sensoryczne 17–19, emocjonalne 20).

Każda grupa zawiera od 2 do 6 deskryptorów, którym przypisano wartość opierającą się na ich pozycji w zestawie słów: pierwsze słowo otrzymuje wartość 1, a następnie wartość 2 itd., odzwierciedlającą poziom intensywności bólu w tej grupie.

Ponadto MPQ obejmuje pięciopunktową skalę odczuwanego bólu (**AIB**), która jest kombinacją liczbowo-werbalną, wskazuje ogólną intensywność bólu i obejmuje 6 poziomów:

0 – brak,
1 – łagodny
2 – lekki (dyskomfort),
3 – średni (umiarkowany),
4 – silny,
5 – nie do wytrzymania.

Do wskaźników, jakie uzyskuje się za pomocą narzędzia MPQ, należą też:

- **LWS** (liczba wybranych słów) – liczba wszystkich zaznaczonych przez badanego określeń dotyczących bólu, przy zachowaniu zasady, że z każdej grupy można wybrać (nie trzeba) tylko jedno określenie (zakres 0–20),
- **WOBr** (wskaźnik oceny bólu oparty na wartościach rangowych – można obliczać również dla aspektów bólu) – suma wartości rangowych przypisanych do dyskryptorów bólu zaznaczonych przez badanego; interpretacja wyniku: większej wartości liczbowej odpowiada większe nasilenie dolegliwości bólowych.

MPQ umożliwia również zaznaczenie lokalizacji bólu na rysunku postaci ludzkiej i określenie jego umiejscowienia (zewnętrzny, wewnętrzny) dzięki zastosowaniu umownych oznaczeń. Ponadto można opisać czasowe charakterystyki bólu, np. czy ból przebiega ciągle, czy z przerwami.

W kwestionariuszu z 1975 roku znajdują się dodatkowe rubryki dotyczące objawów towarzyszących bólowi, tj. wpływu bólu na aktywność życiową, sen, sposób odżywiania, które zostały usunięte z MPQ w 2005 roku [15].

Średni czas wypełniania MPQ to 20 minut, dlatego opracowano również krótką formę kwestionariusza (**SF-MPQ**), na wypełnienie której wystarczy poświęcić 3–4 minuty. Składa się z 15 reprezentatywnych dyskryptorów bólu wybranych z MPQ opisujących dwa aspekty bólu, tj. sensoryczny (**S**, 1–10) i afektywny (**A**, 11–15). Dodatkowo uwzględniono pięciopunktową skalę intensywności oraz wizualną skalę analogową, aby zapewnić wskaźniki ogólnej intensywności bólu.

Kwestionariusz bólu McGill poddano licznym analizom pod względem poprawności merytorycznej, rzetelności, stabilności ocen i zdolności różnicowania badanych. Na tej podstawie uznano go za „złoty standard" oceny bólu [12]. Już pierwsze zastosowanie MPQ w grupie 297 pacjentów cierpiących na kilka rodzajów bólu wykazało, że jest wystarczająco czuły, aby wykryć różnice między stosowanymi metodami łagodzenia bólu, co potwierdziły późniejsze badania. W opracowaniu przeglądowym, na podstawie kilkunastu badań wykazano, że czułość skali wahała się od 77 do 88% [12]. Współczynnik alfa Cronbacha dla adaptowanych licznych wersji MPQ wynosił powyżej 0,70 [16]. Wiarygodność MPQ została zbadana na podstawie próby test-retest i wyniosła 0,70, a efekty czterech powtarzanych pomiarów w populacji chorych na raka potwierdziły wiarygodność kwestionariusza na porównywalnym poziomie (66–80,4%). Badacze zgłaszali wrażliwość MPQ na efekt interwencji przeciwbólowych i stwierdzili, że muzykoterapia zmniejsza intensywność bólu. Dość często prowadzono też badania, w których wykazywano wrażliwość na efekt leczenia [18].

Po 40 latach funkcjonowania MPQ jest niemalże 50 wersji tego narzędzia funkcjonujących w 30 językach, w tym również w języku polskim w adaptacji Kazimierza Sedlaka (1990 rok) i Marty Kołłątaj z zespołem (2013 rok). Niezależnie od metody adaptacji międzykulturowej testy MPQ miały liczne nieprawidłowości bądź nie przeprowadzono względem nich badań klinimetrycznych. Dotyczy to również polskich wersji kwestionariusza, co oznacza, że użytkownicy powinni zachować ostrożność przy interpretacji wyników.

Podsumowując liczne doniesienia badawcze, MPQ jest ważnym i niezawodnym narzędziem, które ocenia zarówno jakość, jak i ilość bólu poprzez zastosowanie unikalnych jego deskryptorów. Może być przydatne w badaniach epidemiologicznych i klinicznych pacjentów dorosłych oraz osób starszych, w szczególności zaś pomóc w identyfikacji bólu typu neuropatycznego. Ograniczeniem MPQ jest bogate słownictwo wymagane od respondentów do jego uzupełnienia. Ponadto różnice płciowe i etniczne mogą wpływać na wybór deskryptorów bólu. Można jednak ułatwić wypełnianie kwestionariusza, zapewniając badanym podczas jego podawania jasne definicje słów (tab. 16.3).

Ateńska skala bezsenności

Ateńska skala bezsenności (Athens Insomnia Scale – **AIS**) jest krótką, ośmiopozycyjną skalą pozwalającą na ilościowy pomiar objawów bezsenności na podstawie kryteriów ICD-10 [21]. W oryginalnych badaniach walidacyjnych wykazano wysoką rzetelność i trafność tego narzędzia. Łączny wynik w skali wynoszący 6 pkt

Tabela 16.3

Ronald Melzack – Kwestionariusz do oceny bólu McGill (McGill Pain Questionnaire – MPQ)

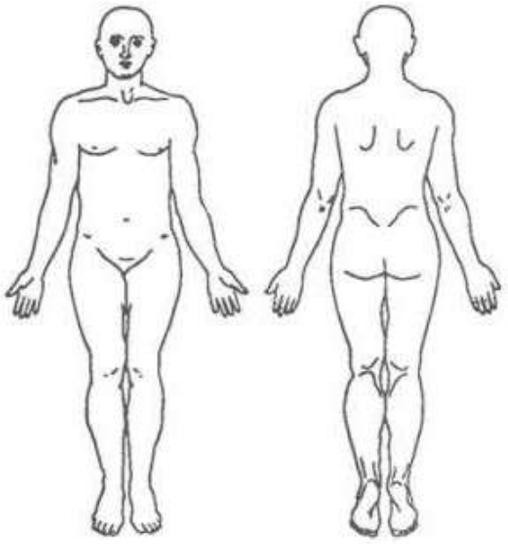
Imię i nazwisko: ..... Data: .....

Liczba wybranych słów (LWS) .....

WOB: S: ..... A: ..... OC: ..... R: ..... WOBr: ..... AIB: .....

1–10 11–15 16 17–20 1–20

1 migoczący ☐ drgający ☐ pulsujący ☐ tętniący ☐ uderzający ☐ łomoczący ☐	10 tkliwy ☐ spinający ☐ piłujący ☐ rozłupujący ☐	20 dokuczliwy ☐ obrzydliwy ☐ wstrętny ☐ nieznośny ☐ torturujący ☐	AIB 0 – brak bólu ☐ 1 – łagodny ☐ 2 – lekki ☐ 3 – średni ☐ 4 – silny ☐ 5 – nie do wytrzymiania ☐
2 drgający ☐ migający ☐ tętniący ☐ strzelający ☐	11 nużący ☐ męczący ☐		
3 kolący ☐ kłujący ☐ drążący ☐ dźgający ☐ świdrujący ☐	12 mdlący ☐ duszący ☐	krótkotrwały ☐ chwilowy ☐ przejściowy ☐	rytmiczny ☐ okresowy ☐ przerywany ☐
4 ostry ☐ tnący ☐ rozcinający ☐	13 niesamowity ☐ straszny ☐ przerażający ☐		ciągły ☐ jednostajny ☐ stały ☐
5 szczypiący ☐ uciskający ☐ ściskający ☐ zgniatający ☐ miażdżący ☐	14 nękający ☐ dręczący ☐ maltretujący ☐ okrutny ☐ zabójczy ☐		
6 rozciągający ☐ rozrywający ☐ rozdzierający ☐	15 oślepiający ☐ porażający ☐		
7 gorący ☐ piekący ☐ parzący ☐ palący ☐	16 nieprzyjemny ☐ przykry ☐ uciążliwy ☐ okropny ☐ nie do zniesienia ☐		
8 mrowiący ☐ swędzący ☐ szczypiący ☐ żądlący ☐	17 rozszerzający się ☐ promieniujący ☐ wciskający się ☐ wdzierający się ☐		
9 stłumiony ☐ przytłumiony ☐ przytępiony ☐ tępy ☐ ciężki ☐	18 napinający ☐ ciągnący ☐ odrętwiający ☐ zaciskający ☐ szarpiący ☐		
	19 chłodny ☐ zimny ☐ lodowaty ☐		



W = wewnętrzny (głęboki)
Z = zewnętrzny (powierzchowny)

Uwagi:

Źródło: Kołłątaj M., Wordliczek J., Dobrogowski J.: *Kwestionariusz do Oceny Bólu McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ)* i skrócona wersja *Kwestionariusza do Oceny Bólu McGill.* Ból, 2013, 14 (3), 10–13. Opracowanie na podstawie: Melzack R.: *The McGill Pain Questionnaire: from description to measurement.* Anesthesiology, 2005, 103 (1), 199–202.

i więcej uznano za wartość pozwalającą z wysokim prawdopodobieństwem wnioskować o występowaniu bezsenności (czułość skali – 93%, swoistość – 85%) [21].

Skala ta należy do najczęściej stosowanych zarówno w celach diagnostycznych, jak i badaniach nad skutecznością leczenia bezsenności. Jest narzędziem samoopisowym, złożonym z ośmiu stwierdzeń odnoszących się do różnych objawów bezsenności. Pięć pierwszych wiąże się z objawami związanymi ze snem i koresponduje z rozpoznaniem bezsenności nieorganicznej według ICD-10. Pozostałe trzy dotyczą funkcjonowania człowieka w czasie codziennej aktywności oraz skargi na konsekwencje bezsenności w ciągu dnia. Każda z pozycji oceniana jest przez badanego w skali 0–3 pkt, gdzie 0 oznacza brak danego objawu, a 3 – jego znaczne nasilenie. Łączny wynik mieści się w przedziale 0–24 pkt.

Ocena wyniku AIS:

≤ 5 pkt – norma, najprawdopodobniej nie ma bezsenności,

6–10 pkt – pogranicze normy, należy się stosować do zasad higieny snu,

> 10 pkt – prawdopodobnie występuje bezsenność, wskazany kontakt z lekarzem w celu uzupełnienia diagnostyki i terapii.

W polskiej adaptacji AIS dokonanej przez Waldemara Szelenbergera z zespołem uzyskano wyższe średnie wyniki od tych w badaniach oryginalnych, co skutkuje przyjęciem wartości 8 pkt i więcej jako pozwalającej z wysokim prawdopodobieństwem (89% prawidłowych kwalifikacji – 94% osób z bezsennością i 84% osób zdrowych) wnioskować o występowaniu bezsenności. Rzetelność polskiej wersji AIS była dość wysoka (współczynnik alfa Cronbacha wynosił 0,90), podobnie jak stabilność bezwzględna wyników (r^2 = 0,92), co wskazuje na przydatność narzędzia w praktyce klinicznej i badaniach naukowych [10].

Diagnoza stanu z wykorzystaniem AIS (wartość < 10 pkt) pokazuje użyteczność stosowania przez pacjenta zasad higieny snu, tj.:

- redukcji czasu spędzanego w łóżku (nawet do 6 godzin),
- niepodejmowania prób zaśnięcia na siłę,
- usunięcia zegarka z zasięgu wzroku w sypialni,
- zmęczenia się fizycznie późnym popołudniem,
- unikania kofeiny, nikotyny i alkoholu,
- prowadzenia regularnego trybu życia,
- jedzenia kolacji 3 godziny przed snem (ewentualnie lekka przekąska wieczorem),
- unikania silnego światła wieczorem i ciemnych pomieszczeń w czasie dnia,
- unikania drzemek w czasie dnia,
- unikania regularnego przyjmowania leków nasennych (tab. 16.4).

Tabela 16.4. Ateńska skala bezsenności

OCENA SNU WEDŁUG AIS				
Proszę zakreślić kwadrat (numer) przy haśle odpowiadającym wymienionym poniżej objawom, jeśli **objawy** te występowały **co najmniej 3 razy w tygodniu w ciągu ostatniego miesiąca**				
POZYCJE	0	1	2	3
1. Zasypianie po położeniu się do łóżka i zgaszeniu światła:	☐ szybkie	☐ nieznacznie opóźnione	☐ opóźnione	☐ bardzo opóźnione lub bezsenność przez całą noc
2. Budzenie się podczas nocy:	☐ nie występuje	☐ sporadycznie	☐ często	☐ bardzo często lub bezsenność przez całą noc
3. Budzenie się rano wcześniej niż planowano:	☐ nie występuje	☐ nieznacznie wcześniej	☐ znacznie wcześniej	☐ dużo wcześniej lub bezsenność przez całą noc
4. Całkowity czas snu:	☐ wystarczający	☐ nieznacznie niewystarczający	☐ wyraźnie niewystarczający	☐ całkowicie niewystarczający lub bezsenność przez całą noc
5. Jakość snu, niezależnie od czasu jego trwania:	☐ satysfakcjonująca	☐ nieznacznie niesatysfakcjonująca	☐ wyraźnie niesatysfakcjonująca	☐ całkowicie niesatysfakcjonująca
6. Samopoczucie następnego dnia:	☐ dobre	☐ nieznacznie gorsze	☐ wyraźnie gorsze	☐ wybitnie gorsze
7. Sprawność psychiczna i fizyczna następnego dnia:	☐ niezaburzona	☐ nieznacznie zaburzona	☐ wyraźnie zaburzona	☐ wybitnie zaburzona
8. Senność w ciągu dnia:	☐ nie zdarza się	☐ nieznaczna	☐ wyraźna	☐ bardzo nasilona

Źródło: Fornal-Pawłowska M., Wołyńczyk-Gmaj D., Szelenberger W.: *Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności*. Psych. Pol., 2011, t. XLV, 2, 211–221.

OCENA STANU OSOBY STARSZEJ

Skala Barthel

Skala Barthel (Bathel scale; Barthel ADL Index) została opracowana w 1955 roku przez Dorotheę Barthel jako prosty wskaźnik niezależności pacjenta z zaburzeniem nerwowo-mięśniowym lub mięśniowo-szkieletowym poprzez ocenę jego zdolności do dbania o siebie i okresowe powtarzanie testu do oceny zwiększania jego niezależności. Współcześnie, w uproszeniu określa się, że służy analizie sprawności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego (activities of daily living). Do oceny wykorzystuje samodzielność pacjenta w zakresie wykonywania 10 codziennych czynności, do których przypisane są punkty o zróżnicowanej wartości, od 0 do 15.

Interpretacja wyników skali:

100–85 pkt – stan funkcjonalny dobry,

84–20 pkt – upośledzenie funkcjonalne średnio ciężkie,

< 20 pkt – ciężka niesprawność [4].

Czas trwania oceny waha się od 3 do 5 minut. Indeks Barthel jest proponowany jako standardowy wskaźnik wykorzystywany do celów klinicznych i badawczych. Skala Barthel jest rekomendowana przez departament australijskiego rządu jako jedna z kilku skal możliwych do zastosowania w celu oceny aktywności fizycznej u osób starszych. Nie należy stosować zmodyfikowanych wersji skali, gdyż nie zawsze były one poddane odrębnemu procesowi walidacji.

Skala Barthel (wartość poniżej 40 pkt) jest uznanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia narzędziem kwalifikacji do objęcia pacjenta opieką zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego czy opieką długoterminową w warunkach domowych [8]. W wielu krajach Europy Zachodniej stosowana jest do obliczania poziomu zapotrzebowania na opiekę. Przyjmuje się, że zapotrzebowanie to jest niewielkie, gdy pacjent uzyska 86–100 pkt, umiarkowane przy 21–85 pkt i bardzo duże przy 0–20 pkt.

Właściwości psychometryczne skali były oceniane niezależnie przez naukowców z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Japonii. Wyniki tych analiz wskazują dość jednoznacznie, że indeks Barthel jest prawidłową miarą niepełnosprawności, niezależnie od osoby, która się nim posługuje (pacjent, pielęgniarka, rodzina, opiekun), wiarygodną i niezawodną. Rzetelność skali Barthel szacowana współczynnikiem alfa Cronbacha wynosiła 0,93. Analiza czynnikowa ujawniła, że jeden czynnik wyjaśniał opiekę nad starszymi mieszkańcami [19] (tab. 16.5).

Tabela 16.5. Skala Barthel

OCENA NIEZALEŻNOŚCI WEDŁUG SKALI BARTHEL			
CZYNNOŚĆ	NIE POTRAFI	POTRAFI Z POMOCĄ	POTRAFI SAMODZIELNIE
1 Spożywanie posiłków	0	5	10
2 Przechodzenie z łóżka na wózek i odwrotnie	0	5	15
3 Utrzymanie higieny osobistej	0	0	5
4 Korzystanie z WC	0	5	10
5 Mycie/kąpiel całego ciała	0	0	5
6 Przejście 50 m (z ewentualną pomocą sprzętu)	0	5	10
7 Chodzenie po schodach	0	5	10
8 Jazda na wózku	0	0	5
9 Ubieranie się i rozbieranie	0	5	10
10 Kontrola zwieraczy odbytu	0	5	10
11 Kontrola zwieraczy pęcherza moczowego	0	5	10

Źródło: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): *Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów*. Wyd. ViaMedica, Gdańsk 2006.

Geriatryczna skala depresji

Geriatryczna skala depresji (Geriatric Depression Scale – GDS) została opracowana w 1983 roku przez Jerome'a Yesavage'a i współpracowników jako narzędzie przesiewowe umożliwiające dokonywanie oceny natężenia symptomów depresji u osób w starszym wieku. Wersja oryginalna składa się z 30 krótkich pytań z dwiema możliwościami odpowiedzi do wyboru (tak/nie). Pytania wchodzące w skład GDS zostały wybrane z puli stu pytań służących do oceny różnorodnych przejawów życia psychicznego związanych z depresją (nastrój, motywacja, objawy somatyczne, obraz „ja" itp.). Współczynnik rzetelności alfa Cronbacha wynosił 0,94, a czułość i specyficzność skali – odpowiednio 84 i 95%. Wyniki uzyskane po zastosowaniu GDS korelowały z wynikami inwentarza depresji Becka (r = 0,91) [24].

Geriatryczna skala depresji jest narzędziem stosowanym na całym świecie. Istnieje wiele jej tłumaczeń (np. polska, chińska, duńska, francuska, hebrajska, hiszpańska, indyjska, meksykańska, niemiecka, portugalska, turecka) oraz skróconych wersji [2]. Polska wersja GDS została przetłumaczona i użyczona do wykorzystania w praktyce opieki zdrowotnej przez firmę Servier Polska. W literaturze nie stwierdzono danych na temat pomyślnie zakończonej procedury adaptacji

kulturowej i walidacji psychometrycznej polskiej wersji GDS. Jedynie Bidzan i współpracownicy oszacowali specyficzność i czułość 30-itemowej GDS. Czułość skali wyniosła 81%, a specyficzność – 47%, co sugeruje stosowanie tej skali do badań przesiewowych w kierunku wstępnej diagnozy depresji [5]. Skrócona 15-pozycyjna wersja GDS jest wykorzystywana w całościowej ocenie geriatrycznej zalecanej przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

W 30-pozycyjnej skali GDS-LF (long form) wyniki interpretuje się następująco:

0–10 pkt – brak depresji,

11–20 pkt – lekka depresja,

21–30 pkt – głęboka depresja.

Natomiast 15-pozycyjna wersja GDS-SF (short form) pozwala na następującą interpretację wyników:

0–5 pkt – brak depresji,

6–15 pkt – depresja.

Zaprezentowane powyżej punkty odcięcia zapewniają optymalną czułość (84%) i specyficzność (95%) skali. Chociaż w literaturze można spotkać również interpretację trójpoziomową, tj. 0–5 pkt – brak depresji, 6–10 – depresja umiarkowana, 11–15 – depresja ciężka, trudno jest dla tej interpretacji wskazać parametry czułości i swoistości pomiaru. Należy też podkreślić, że ze względu na samoopisowy charakter GDS oraz częste stosowanie skróconych wersji skali o nieokreślonych właściwościach różnicujących, uzyskany wynik pomiaru nie jest w stanie zastąpić wywiadu klinicznego ani złożonego procesu diagnozy (tab. 16.6).

Tabela 16.6. Geriatryczna skala depresji

OCENA DEPRESJI WEDŁUG 15-PUNKTOWEJ GDS		
Proszę ocenić swoje samopoczucie **w ciągu ostatnich 2 tygodni**, zakreślając właściwą odpowiedź		
1	Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan/i zadowolony/a?	tak/nie
2	Czy zmniejszyły się Pana/i zainteresowania lub aktywność (liczba zajęć)?	tak/nie
3	Czy ma Pan/i uczucie, że Pana/i życie jest puste?	tak/nie
4	Czy często czuje się Pan/i znudzony/a?	tak/nie
5	Czy zwykle jest Pan/i w dobrym nastroju?	tak/nie
6	Czy obawia się Pani/i, że może się Panu/Pani przydarzyć coś złego?	tak/nie
7	Czy przez większość czasu czuje się Pan/i szczęśliwy/a?	tak/nie
8	Czy często czuje się Pan/i bezradny/a?	tak/nie
9	Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan/i w nim pozostać?	tak/nie
10	Czy uważa Pan/i, że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni?	tak/nie
11	Czy uważa Pan/i, że wspaniale jest żyć?	tak/nie
12	Czy czuje się Pan/i gorszy/a od innych ludzi?	tak/nie
13	Czy czuje się Pan/i pełen/pełna energii?	tak/nie
14	Czy uważa Pan/i, że sytuacja jest beznadziejna?	tak/nie
15	Czy myśli Pan/i, że większości ludzi wiedzie się lepiej niż Panu/Pani?	tak/nie
Podsumowanie: za każdą zakreśloną odpowiedź – 1 pkt Liczba punktów: ……/15		

Źródło: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): *Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów*. Wyd. ViaMedica, Gdańsk 2006; Albiński R., Kleszczewska-Albińska A., Bedyńska S.: *Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia – przegląd badań*. Psych. Pol., 2011, t. XLV (4), 555–562.

PODSUMOWANIE

Przedstawione przykładowe skale/testy/kwestionariusze diagnostyczne, możliwe do stosowania przez pielęgniarki lub położne do oceny stanu zdrowia chorego, nie stanowią przeglądu tematycznie spójnego. Jego celem jest raczej pokazanie różnorodności możliwości i wskazanie istotnych wskaźników klinimetrycznych ważnych w czasie wyboru skal do oceny stanu zdrowia pacjenta.

Pielęgniarka, gromadząc informacje subiektywne w czasie rozmowy z pacjentem, wykonując pomiary, stosując skale klinimetryczne (np. skala Glasgow, skala Norton, skala Braden, skala Apgar), analizując informacje pozyskane z badań diagnostycznych, potrafi określić stan chorego i sformułować rozpoznanie

pielęgniarskie, ustalić plan opieki oraz stale ewaluować przebieg procesu pielęgnowania zindywidualizowanego.

Dla systematyzacji toku myślenia należy wspomnieć, że współczesne rozumienie procesu pielęgnowania jako terminu opisującego system interwencji pielęgniarki znaczących dla zdrowia jednostki, rodziny i/lub społeczności składa się z 5 etapów. Etapy te, określane akronimem **ADPIE,** to: ocena (**A**ssessment), diagnoza (**D**iagnosis), planowanie (**P**lanning), realizowanie (**I**mplementation) i ewaluacja (**E**valuation) [1].

Zgromadzone informacje o sytuacji zdrowotnej pacjenta – zarówno subiektywne, jak i obiektywne (tab. 16.7) – oraz każdy kolejny etap pracy z nim powinny być dokumentowane docelowo w elektronicznej dokumentacji zdrowia (Electronic Health Record – EHR), co wymaga stosowania standaryzowanej terminologii pielęgniarskiej (Standardized Nursing Terminologies – SNT). W wyniku systematycznego przeglądu literatury (bazy danych PubMed i CINAHL), którego celem była identyfikacja badań z wykorzystaniem danych SNT, wykazano, że zestaw terminologii NNN zawierający klasyfikacje NOC (Nursing Outcomes Classification; klasyfikcja wyników opieki), NANDA-I (NANDA-International; klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich) i NIC (Nursing Interventions Classification; klasyfikacja interwencji pielęgniarskich) jest wykorzystywany najczęściej do kodowania danych pielęgniarskich. Zastosowanie SNT do kodowania danych pielęgniarskich umożliwia agregację podstawowej części EHR w zestawach dużych zbiorów danych oraz określenie, poprzez zaawansowane analizy statystyczne, znaczenia/ /udziału opieki pielęgniarskiej w efekcie zdrowienia pacjenta. Zaletą terminologii standaryzowanej NNN jest jej związek z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), co pozwala na koherentne budowanie bazy informatycznej EHR (tab. 16.8).

Tabela 16.7. Fragment dokumentacji dydaktycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo opracowanej przez zespół nauczycieli Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (wersja 2015, komputeropis)

UKŁAD ODDECHOWY	**Oddech**	prawidłowy ☐ częstość: …… miarowy: TAK ☐ NIE ☐ nieprawidłowy ☐ spłycony ☐ świszczący ☐ charczący ☐ chrypka ☐ stany bezdechu ☐ pogłębiony ☐ sztuczna droga oddechowa: NIE ☐ TAK ☐ rurka: tracheostomijna ☐ intubacyjna ☐	**Objaw**		
			O		
			L		
			D		
	Duszność	NIE ☐ TAK ☐ wysiłkowa ☐ spoczynkowa ☐	**C**		
	Katar	NIE ☐ TAK ☐	**A**		
	Zaleganie wydzieliny	NIE ☐ TAK ☐ odkrztuszanie: samodzielne ☐ utrudnione ☐ plwocina: śluzowa ☐ śluzowo-ropna ☐ inna ……	**R**		
			T		
	Kaszel	NIE ☐ TAK ☐ suchy ☐ wilgotny ☐ napadowy ☐ przewlekły ☐ pokasływanie ☐ szczekający ☐	Skala Wynik	…… ……	…… ……
	Badanie fizykalne	oglądanie: …… obmacywanie: …… opukiwanie: …… osłuchiwanie: ……			
	Inne				

Tabela 16.8. Struktura SOAP (IER) a opieka pielęgniarska zindywidualizowana z wykorzystaniem terminologii NANDA

SOAP (IER)	OPIEKA PIELĘGNIARSKA	TERMINOLOGIA NANDA
S informacje subiektywne **O** informacje obiektywne	**A** gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta	**NOC** klasyfikacja wyników opieki: standaryzowane terminy w 5-stopniowej skali Likerta do opisu stanu pacjenta oraz skale klinimetryczne
A ocena danych, diagnoza	**D** formułowanie diagnoz pielęgniarskich	**NANDA- I** klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich: standaryzowane terminy w liczbie ponad 200
P planowanie **I** interwencja	**P** planowanie opieki **I** implementacja planu, realizacja opieki	**NIC** klasyfikacja interwencji pielęgniarskich: standaryzowane interwencje pielęgniarskie oparte na wynikach badań naukowych (evidence based nursing – EBN, evidence based medicine – EBM, evidence based – EB)
E ewaluacja **R** rewizja	**E** ewaluacja wyników i formułowanie stanu w kategorii nowej diagnozy	**NOC** klasyfikacja wyników opieki: standaryzowane terminy w 5-stopniowej skali Likerta do opisu stanu pacjenta oraz skale klinimetryczne

16.2. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO NA POTRZEBY OCENY STANU ZDROWIA

Formułowanie wstępnej oceny stanu zdrowia na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego zostanie przedstawione w oparciu o opis sytuacji zdrowotnej pacjentki zgłaszającej się do pielęgniarki zaawansowanej praktyki[2].

[2] Pielęgniarka zaawansowanej praktyki (Advanced Practice Nurse – APN) – według Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (2002) oraz definicji międzynarodowych – jest zarejestrowaną pielęgniarką, która nabyła gruntowną specjalistyczną wiedzę (zalecaną na poziomie magisterskim), kompleksowe umiejętności podejmowania decyzji i kliniczne kompetencje do wykonywania poszerzonej praktyki oraz charakterystyczne cechy, ukształtowane w kraju, w którym zezwolono pielęgniarce tę praktykę realizować, np. specjalizacje zawodowe, kursy, studia podyplomowe.

OPIS SYTUACJI ZDROWOTNEJ PACJENTKI

Pani K. zgłosiła się 24.10.2019 roku o godz. 17.30 do poradni ZOZ z powodu bardzo silnego bólu głowy, zawrotów i nudności.

Informacje podstawowe

We wstępnej rozmowie ustalono, że pacjentka ma 48 lat, logicznie odpowiada na zadawane pytania, co pozwala sądzić o wiarygodności przedstawianych informacji. Jest sprzedawczynią w sklepie spożywczym i dzisiaj pracowała od godz. 6.00 do 16.00. Wcześniej nigdy nie odczuwała tak silnych dolegliwości bólowych o charakterze pulsującym. Z bólem głowy o mniejszym nasileniu, występującym sporadycznie, radziła sobie poprzez przyłożenie mokrego ręcznika na czoło, wypoczynek i sen albo zażywając doustne leki – paracetamol, zwykle w dawce 500 mg w postaci tabletki, jednorazowo. Pacjentka zgłaszała, że w pracy uczestniczyła dzisiaj w kłótni z koleżankami, w wyniku której musiała zastąpić w wykonywaniu obowiązków jedną z nich. Ból pojawił się około godz. 14.30 i stale się nasila.

Dane subiektywne

Pacjentka jest bardzo zaniepokojona swoją sytuacją, gdyż jej matka w wieku 55 lat zmarła z powodu udaru mózgu, a mąż 2 lata temu w wyniku tętniaka naczyń mózgowych. Kobieta mieszka sama, syn studiuje w mieście oddalonym o prawie 200 km. Spożywa 3 posiłki dziennie, przy czym jeden w domu. Nie używa napojów wysokoprocentowych, okazjonalnie pije 1–2 kieliszki wina. Natomiast codziennie wypija 2 kubki kawy, a wieczorem coca-colę. Pali papierosy od 23. roku życia, jedną paczkę dzienne (25 paczkolat). Nie ma uczuleń na leki i produkty spożywcze. Na stałe od 2 lat przyjmuje doustnie lek o nazwie Co-Prenessa 1 tabletkę 5 mg rano, a od 2 tygodni Bodymax doustnie 1 tabletkę dziennie. W przeszłości chorowała rzadko, wspomina o zapaleniu oskrzeli 8 lat temu. W wywiadzie położniczo-ginekologicznym bez wskazywania na dolegliwości. Pacjentka ostatnie badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy wykonywała w 2010 roku, wynik był prawidłowy. W dzieciństwie przechorowała: ospę wietrzną, odrę, świnkę i różyczkę. Szczepienia wówczas wykonywała regularnie, teraz z nich nie korzysta, twierdząc, że są dla dzieci. Pacjentka średnio raz w miesiącu wybiera się na długi spacer do lasu. Posiada prawo jazdy kat. B, przemieszcza się 20-letnim samochodem marki Volvo.

Pielęgniarka, przejmując opiekę nad pacjentką, rozmawiając, gromadzi informacje o funkcji narządów i układów. Zapisuje je czytelnie w dokumentacji uzupełniającej, podobnie jak wcześniej zgromadzone informacje.

Funkcje układów anatomiczno-fizjologicznych

Objawy ogólne: masa ciała bez zmian, nadwaga; pacjentka do tej pory nie odczuwała zmian samopoczucia, w dniu dzisiejszym jest zdenerwowana zdarzeniem w pracy.

Skóra: pacjentka zgłasza uczucie suchości skóry dłoni oraz pojedyncze przebarwienia, które ma od 5 miesięcy; nie zauważa zmian patologicznych; wytwory skóry (włosy, paznokcie) określa jako prawidłowe.

Głowa, słuch, wzrok, jama ustna, gardło: głowa bez urazów, słuch w ocenie pacjentki prawidłowy, podobnie jak stan uzębienia (wizyty u stomatologa systematyczne, co pół roku); używa okularów do czytania.

Szyja: kobieta nie zauważa zmian patologicznych.

Piersi: na skórze prawej piersi zmiana o barwie jasnobrunatnej, którą pacjentka obserwuje od 3 lat, nie wykonuje samobadania piersi.

Układ oddechowy: infekcje górnych dróg oddechowych rzadkie, ostatnio kobieta zauważyła występowanie kaszlu rano, tuż po wstaniu z łóżka, o charakterze suchym.

Układ krążenia: okresowo stwierdzano podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, leczone farmakologicznie od śmierci męża.

Układ pokarmowy: apetyt dość dobry; wypróżnienia z częstością raz na dwa dni; biegunka rzadko, najczęściej po błędzie dietetycznym.

Układ moczowo-płciowy: wydalanie moczu pacjentka ocenia jako prawidłowe, chociaż od miesiąca zaobserwowała zwiększoną objętość wydalanego moczu, w tym konieczność korzystania z toalety w nocy; dolegliwości ze strony narządów płciowych nie zgłasza; miesiączka regularna, co 28–30 dni; orientacja heteroseksualna, aktualnie nieaktywna seksualnie.

Obwodowy układ naczyniowy: żylaki powierzchowne na kończynie dolnej lewej, które ujawniają się wieczorem po całodziennej pracy w pozycji stojącej.

Układ ruchu: okresowy ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, w opinii pacjentki mający związek z przeciążeniem fizycznym w pracy.

Problemy neuropsychiatryczne: pacjentka nie podaje.

Dane obiektywne – wyniki badania fizykalnego

Pani K. jest kobietą zadbaną, w średnim wieku. Wyraz twarzy wskazuje na zmęczenie. Przejawia umiarkowane zdenerwowanie.

Pomiary podstawowych funkcji życiowych: masa ciała – 73 kg, wzrost – 164 cm, wskaźnik masy ciała – 27,14 kg/m^2; ciśnienie tętnicze krwi – 159/94 mmHg (L) i 146/89 mmHg (P); rytm serca miarowy o częstości 78 uderzeń/minutę; oddech regularny o częstości 17/minutę; temperatura ciała mierzona na czole – 36,4°C.

Skóra: pojedyncze zmiany barwnikowe zlokalizowane na przedramionach o średnicy 1–2 mm, płaskie, barwy brunatnej.

Głowa, słuch, wzrok, jama ustna, gardło: w palpacji nie stwierdzono zmian kształtu głowy, tkliwości uciskowej; próba Webera i test Rinnego wskazują na prawidłowy słuch; uzębienie prawidłowe; ostrość wzroku w okularach korekcyjnych, OP – 0,8, OL – 1,0, test Ishihary prawidłowy, pole widzenia prawidłowe (metoda konfrontacyjna).

Szyja: bez wyczuwalnych zgrubień, tkliwości i bolesności.

Piersi: na prawej piersi zmiana barwnikowa, zlokalizowana pomiędzy godziną 3 a 4 według tarczy zegara, kształtu owalnego, o wymiarach 2×3 mm, płaska, o barwie jasnobrunatnej.

Układ oddechowy: wypuk jawny nad polami płuc, stłumienie przeponowe na poziomie X międzyżebrza; osłuchowo szmer pęcherzykowy i pęcherzykowo-oskrzelowy, symetryczny.

Układ krążenia: stłumienie względne serca prawidłowe, czynność serca miarowa, około 80 uderzeń/minutę, T_1 i T_2 dobrze słyszalne, T_3 i T_4 nieobecne; test Allena – 8 sekund.

Układ pokarmowy: brzuch symetryczny, płaski, pępek wklęsły, tętnienie aorty brzusznej widoczne, ruchy perystaltyczne jelit obecne, opukowo słyszalny odgłos bębenkowy, wielkość wątroby w linii środkowo-obojczykowej 9 cm, a w linii środkowej 4,5 cm; narządy jamy brzusznej niebadalne i niebolesne; objawy Blumberga, Chełmońskiego i Murphy'ego ujemne; pacjentka dziennie wypija około jednego litra płynów.

Układ moczowo-płciowy: nerki niebadalne i niebolesne, dno pęcherza moczowego na wysokości spojenia łonowego, objaw Goldflama ujemny.

Obwodowy układ naczyniowy: widoczne rozszerzone naczynia w przebiegu żyły piszczelowej przedniej z towarzyszącym stwardnieniem; żylaki powierzchowne na kończynie dolnej lewej, ucieplenie kończyn prawidłowe; objaw dołka na grzbiecie stóp nie występuje.

Układ ruchu: fizjologiczny zakres ruchów w stawach, siła mięśni zginaczy i prostowników 5 według skali Lovetta, brak objawów stanu zapalnego stawów; okresowo przemijający samoistnie ból pleców w okolicy lędźwiowej o natężeniu 4 pkt według skali VAS (Visual Analogue Scale).

Układ nerwowy: test MMSE 29 pkt, hiposmia obustronna, czucie i ruchomość mięśni twarzy prawidłowe, odruch rogówkowy obecny, rozpoznawalność smaku prawidłowa, próba Romberga prawidłowa, mowa prawidłowa, zdolność połykania prawidłowa, czucie powierzchowne i głębokie prawidłowe; odruchy głębokie ścięgniste z mięśnia dwugłowego, z mięśnia trójgłowego, mięśnia ramienno-promieniowego, zgięciowy palców, rzepkowy i skokowy obecne na 2 +, symetryczne; odruchy powierzchniowe brzuszne i podeszwowe obecne na 2 +, symetryczne; objawy sztywności karku, Brudzińskiego i Kerniga ujemne.

Pielęgniarka po analizie zgromadzonych informacji subiektywnych (S) i obiektywnych (O), dążąc do ich kompletności, zadała jeszcze kilka pytań, w wyniku których stwierdziła, że: objaw kaszlu występuje od 3 miesięcy, ma charakter napadowy, bez odkrztuszania wydzieliny, nie występuje podwyższona temperatura, kaszel nasila się rano, łagodzi go ssanie cukierków miętowych „Pszczółka". Z powodu kaszlu pacjentka nie bierze żadnych leków. Lek Co-Prenessa przyjmuje rano po śniadaniu. Nie prowadzi dzienniczka samokontroli ciśnienia tętniczego krwi. Syn Pani K. nie pali papierosów, jest szczupły i zainteresowany zdrowiem matki, przyjeżdża do domu systematycznie co 2 tygodnie.

Pielęgniarka dokonała oceny danych (A) odzwierciedlających sytuację zdrowotną pacjentki i zwróciła uwagę na: nadciśnienie tętnicze leczone i aktualny wzrost wartości RR, brak systematycznej aktywności ruchowej, nikotynizm i kaszel suchy, okresowe dolegliwości bólowe kręgosłupa (VAS – 4 pkt), zwiększone wydalanie moczu, hiposmię, BMI 27,14 kg/m^2, wykonywanie wyłącznie wybranych badań profilaktycznych. Na podstawie wyodrębnionego zestawu istotnych danych dokonała ich syntezy, wskazując diagnozy pielęgniarskie, wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz gwarantowane legislacyjnie uprawnienia (*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej*).

Pielęgniarka, formułując diagnozy pielęgniarskie, zastosowała standaryzowaną terminologię pielęgniarską – SNT [1]. Powstała lista diagnoz:

- **Nieefektywne podtrzymywanie zdrowia związane z brakiem wiedzy na temat leczenia i kontroli procesu choroby.**
- **Zmiany w zakresie podtrzymywania zdrowia związane z wypieraniem skutków palenia, brakiem wsparcia.**
- **Ryzyko wystąpienia zaburzeń bilansu płynów, czynniki ryzyka: nadciśnienie tętnicze, zmiana funkcjonowania nerek.**

Nieefektywne podtrzymywanie zdrowia związane z brakiem wiedzy na temat leczenia i kontroli procesu choroby:

- Zalecenie przyjmowania leku Co-Prenessa 1 tabletka 5 mg na pół godziny przed śniadaniem – zmiana pory zażywania leku.
- Zalecenie stosowania doustnie syropu Neospasmina w dawce 10 ml 2 razy dziennie.
- Motywowanie w czasie rozmowy do systematycznej codziennej kontroli RR i prowadzenia dzienniczka samokontroli RR.
- Zachęcanie do prowadzenia badań profilaktycznych: samobadanie piersi (pokaz samobadania na fantomie), badania spirometryczne (wskazanie możliwości skorzystania z programu profilaktycznego).
- Skierowanie do poradni dietetycznej w celu ustalenia spersonalizowanej diety.
- Rozmowa edukacyjna zachęcająca do rekreacyjnego uprawiania aktywności fizycznej (np. aerobik lub jazda na rowerze co najmniej 150 minut w tygodniu).
- Skierowanie na EKG w spoczynku, lipidogram.
- Skierowanie do poradni okulistycznej w celu pogłębionej diagnostyki ostrości wzroku i wyboru szkieł korekcyjnych.
- Skierowanie do poradni dermatologicznej w celu diagnostycznym – oceny zmiany barwnikowej na skórze piersi.

Zmiany w zakresie podtrzymywania zdrowia związane z wypieraniem skutków palenia, brakiem wsparcia:

- Stopień uzależnienia od nikotynizmu: kwestionariusz Fagerströma (5 pkt).
- Ocena motywacji do zaprzestania palenia: test motywujący do zaprzestania palenia według Schneider (8 × „tak”).
- Skierowanie na zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej.
- Rozmowa edukacyjna wraz z pokazem skutków palenia tytoniu na modelu „palacz”.
- Zachęcanie do porzucenia nałogu, co być może przyczyni się do zlikwidowania kaszlu i powrotu prawidłowego węchu.
- Nawiązanie kontaktu z synem Pani K. jako sojusznikiem w porzuceniu nałogu palenia i osobą znaczącą dla pacjentki.

Ryzyko wystąpienia zaburzeń bilansu płynów, czynniki ryzyka: nadciśnienie tętnicze, zmiana funkcjonowania nerek:

- Skierowanie na badanie ogólne moczu.
- Skierowanie na badanie biochemiczne krwi: określenie stężenia elektrolitów Na i K oraz glukozy.
- Edukacja w zakresie ilości, jakości oraz sposobu picia płynów.

IMPLEMENTACJA PLANU

Wdrożenie planu postępowania stanowi autonomiczną decyzję pacjentki. Zaproszenie na wizytę za 2 tygodnie pozwoli na ocenę zaangażowania pacjentki w dbanie o swoje zdrowie oraz stanu zdrowia na podstawie wykonanych badań i zrealizowanych zaleceń. Gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej pacjentki będzie ukierunkowane na: nadciśnienie tętnicze leczone i aktualne wartości RR, systematyczną aktywność ruchową, nikotynizm i kaszel, okresowe dolegliwości bólowe kręgosłupa, zwiększone wydalenie moczu, hiposmię, nadwagę, wykonywanie badań profilaktycznych.

REWIZJA POSTĘPOWANIA

Pielęgniarka, w zależności od uzyskanych przez pacjentkę zmian w stanie zdrowia, zaproponuje utrzymanie dotychczasowego postępowania lub jego korektę.

Systematyczne rozszerzanie kompetencji i uprawnień pielęgniarek obserwowane w ostatnim czasie dość znacznie zwiększa również ich odpowiedzialność za świadczenia zdrowotne oraz zakres współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia. Ze względów formalnych zwiększa to też zakres prowadzonej dokumentacji, która stanowiąc dowód w sprawie jakości sprawowanej opieki, musi spełniać na etapie tworzenia reguły poprawności merytorycznej sformułowane w tym rozdziale.

PIŚMIENNICTWO

1. Ackley B.J., Ladwig G.B.: Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych. GC Media House, Warszawa 2011.
2. Albiński R., Kleszczewska-Albińska A., Bedyńska S.: Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia – przegląd badań. Psych. Pol., 2011, t. XLV (4), 555–562.
3. Andrus M.R., McDonough S., Kelley K.W. i wsp.: Development and validation of a rubric to evaluate diabetes SOAP note writing in APPE. Am. J. Pharm. Educ., 2018, 82 (9), 6725; doi:10.5688/ajpe6725.
4. AOTMiT: Analiza dowodów naukowych potwierdzających zasadność stosowania wybranych skal do oceny pacjenta w ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019.
5. Bidzan L., Łapin J., Sołtys K., Turczyński J.: Geriatryczna Skala Depresji (Geriatric Depression Scale) jako pomocnicze narzędzie diagnostyczne u pacjentów powyżej 55. roku życia. Psych. Pol., 2002, 36 (6), 187–192.
6. Crellin D.J., Harrison D., Santamaria N., Babl F.: Systematic review of the Face, Legs, Activity, Cry and Consolability scale for assessing pain in infants and children: is it reliable, valid, and feasible for use? Pain, 2015, 156 (11), 2132–2151; doi:10.1097/j.pain.0000000000000305.
7. Crellin D.J., Harrison D., Santamaria N. i wsp.: The psychometric properties of the FLACC Scale used to assess procedural pain. J. Pain, 2018, 19 (8), 862–872; doi.org/10.1016/j.jpain.2018.02.013.
8. Fedyk-Łukasik M.: Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej. Geriatr. Opieka Długoterm., 2015, 1 (1), 1–5.
9. Feinstein A.R.: An additional basic science for clinical medicine: IV. The development of clinimetrics. Ann. Intern. Med., 1983, 99 (6), 843–848.
10. Fornal-Pawłowska M., Wołyńczyk-Gmaj D., Szelenberger W.: Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psych. Pol., 2011, t. XLV, 2, 211–221.
11. Gossman W., Lew V., Ghassemzadeh S.: SOAP Notes. Source Stat Pearls [Internet]. Treasure Island (FL), Stat Pearls Publishing, 2019.
12. Katz J., Melzack R.: The McGill Pain Questionnaire: Development, psychometric properties, and usefulness of the long form, short form, and short form-2. W: Turk D.C., Melzack R. (red.): Handbook of Pain Assessment. The Guilford Press, 2011.

13. Kołłątaj M., Wordliczek J., Dobrogowski J.: Kwestionariusz do Oceny Bólu McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ) i skrócona wersja Kwestionariusza do Oceny Bólu McGill. Ból, 2013, 14 (3), 10–13.
14. Lenert L.A.: Toward medical documentation that enhances situational awareness learning. AMIA Symposium, 2016, 763–771.
15. Melzack R.: The McGill Pain Questionnaire: From description to measurement. Anesthesiology, 2005, 103 (1),199–202.
16. Menezes C.L., Maher C.G., McAuley J.H., Costa L.O.: Systematic review of cross-cultural adaptations of McGill Pain Questionnaire reveals a paucity of clinimetric testing. J. Clin. Epidemiol., 2009, 62, 934– 943.
17. Merkel S.I., Voepel-Lewis T., Shayevitz J.R., Malviya S.: FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. Pediatr. Nurs., 1997, 23 (3), 293–297.
18. Ngamkham S., Vincent C., Finnegan L. i wsp.: The McGill Pain Questionnaire as a multidimensional measure in people with cancer: an integrative review. Pain Manag. Nurs., 2012, 13 (1), 27–51; doi:10.1016/j.pmn.2010.12.003.
19. Ohura T., Higashi T., Ishizaki T., Nakayama T.: Assessment of the validity and internal consistency of a performance evaluation tool based on the Japanese version of the modified Barthel index for elderly people living at home. J. Phys. Ther. Sci., 2014, 26 (12), 1971–1974; doi:10.1589/jpts.26.1971.
20. Przedpełska-Winiarczyk M., Kułak W.: Skala Apgar obecnie. Probl. Hig. Epidemiol., 2011, 92 (1), 25–29.
21. Soldatos C.R., Dikeos D.G., Paparrigopoulos T.J.: The diagnostic validity of the Athens Insomnia Scale. J. Psychosom. Res., 2003, 55, 263–267.
22. Szczudlik A.: Propozycja stworzenia polskiego „języka bólu". Neural. Neurochir. Pol., 1983, 17, 547–552.
23. Voepel-Lewis T., Zanotti J., Dammeyer J.A., Merkel S.: Reliability and validity of the face, legs, activity, cry, consolability behavioral tool in assessing acute pain in critically ill patients. Am. J. Crit. Care, 2010, 19 (1), 55–61; doi:10.4037/ajcc2010624. PMID 20045849.
24. Yesavage J.A., Brink T.L., Rose T.L. i wsp.: Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J. Psychiatr. Res., 1982–1983, 17 (1), 37–49; doi.org/10.1016/0022-3956(82)90033-4.

PYTANIA SPRAWDZAJĄCE

Rozdział 1

1. Wyjaśnij pojęcie „tożsamość kulturowa".
2. W jaki sposób można rozwijać własną wrażliwość kulturową (podaj przykłady)?
3. Jakie czynniki kulturowe należy uwzględnić, przeprowadzając badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta odrębnego kulturowo?

Rozdział 2

1. Jakich zasad należy przestrzegać w czasie badania podmiotowego?
2. Jakie sytuacje utrudniają prowadzenie wywiadu z pacjentem?
3. Na czym polega podejście do badania podmiotowego oparte na systemie Calgary–Cambridge?
4. W jakiej kolejności należy zadawać pytania według OLDCART?

Rozdział 3

1. Jak wygląda ustalona pozycja anatomiczna ciała?
2. Jakie informacje uzyskasz, wykonując badanie fizykalne metodą opukiwania?
3. Wartości jakich parametrów są podstawą oceny stanu odżywienia?
4. Jaki wpływ ma szerokość mankietu opaski ciśnieniomierza na wartość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi?

Rozdział 4

1. Jakie cechy skóry zbadasz metodą palpacyjną?
2. Scharakteryzuj strukturę owłosienia skóry osoby dorosłej.
3. Omów budowę prawidłowej płytki paznokciowej i podaj przykłady zmian chorobowych paznokci.
4. Podaj cechy prawidłowych węzłów chłonnych.
5. Wymień węzły chłonne kończyn górnych i kończyn dolnych, a następnie opisz sposób badania tych węzłów.

Rozdział 5

1. Omów zasady badania ostrości wzroku.
2. Opisz sposób oceny źrenic oraz podaj wnioski wynikające z badania w warunkach prawidłowych.
3. Omów technikę badania reakcji źrenic na światło, przedstaw prawidłowy wynik badania.
4. Jak ocenisz drożność nosa?
5. Omów badanie ucha, badanie akumetryczne oraz testy Webera i Rinnego.
6. Opisz metody badania fizykalnego tarczycy.

Rozdział 6

1. Wymień okolice grzbietowej powierzchni klatki piersiowej.
2. Jaki jest stosunek wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej do jej wymiaru bocznego?
3. Określ umiejscowienie gruczołu piersiowego u dorosłych kobiet.
4. Jak przygotować pacjentkę do badania przedmiotowego gruczołów piersiowych?
5. Podaj kryteria opisu guzka gruczołu piersiowego.

Rozdział 7

1. Wymień zasady badania układu oddechowego.
2. Scharakteryzuj cechy prawidłowego oddechu osoby dorosłej.
3. Wymień miejsca opukiwania klatki piersiowej i rodzaje odgłosów opukowych.
4. Scharakteryzuj prawidłowe szmery (dźwięki) oddechowe.

Rozdział 8

1. Określ miejsce uderzenia koniuszkowego.
2. Określ miejsce osłuchiwania zastawki aorty.
3. W jakiej fazie powstaje pierwszy ton serca (S_1)?
4. W jakim celu wykonuje się test Allena?

Rozdział 9

1. Podaj kolejność stosowania metod badania fizykalnego i uzasadnij ich znaczenie w ocenie jamy brzusznej.
2. Omów miejsca i zasady osłuchiwania perystaltyki brzucha.
3. Określ prawidłowe granice wątroby oceniane metodą opukową.
4. Omów ułożenie pacjenta do badania odbytu.

Rozdział 10

1. Wymień zewnętrzne narządy żeńskiego układu płciowego.
2. Opisz zakres rozwoju cech żeńskich narządów płciowych istotnych w ocenie dojrzałości płciowej.
3. Jakie zasady powinny być przestrzegane podczas badania przedmiotowego żeńskich narządów płciowych?
4. Opisz wynik fizjologiczny śluzu szyjkowego.

Rozdział 11

1. Wymień wewnętrzne narządy męskiego układu płciowego.
2. Jakie cechy płciowe składają się na ocenę dojrzałości płciowej mężczyzny?
3. Jakie zasady powinny być przestrzegane podczas badania gruczołu krokowego?

Rozdział 12

1. Określ położenie i funkcje stawu skroniowo-żuchwowego.
2. Jak ocenia się symetrię długości kończyn dolnych?
3. Jaki jest zakres ruchu stawu biodrowego i jak się bada ten staw?
4. Jaki jest zakres badania ruchów stopy?

Rozdział 13

1. Które z nerwów czaszkowych odpowiadają za czucie smaku? Omów technikę badania smaku.
2. Omów ogólne zasady badania czucia.
3. Opisz technikę badania odruchu podeszwowego Babińskiego. Scharakteryzuj możliwe reakcje ruchowe pacjenta, w przypadku gdy odruch ten jest dodatni.

Rozdział 14

1. W których minutach ocenia się stan ogólny noworodka według skali Apgar i dlaczego?
2. Jakie są prawidłowe rozmiary węzłów chłonnych u dzieci?
3. Jaki jest u dziecka zakres oceny układu kostno-stawowego oraz jakie są metody jego badania?
4. Wymień odruchy fizjologiczne u dzieci i podaj czas ich zanikania.

Rozdział 15

1. Wymień zaburzenia i deficyty mające wpływ na występowanie trudności w komunikacji z pacjentem geriatrycznym.
2. Jakie kluczowe informacje należy uzyskać w badaniu podmiotowym od osoby w wieku geriatrycznym?
3. O co powinno się zapytać pacjenta w wieku geriatrycznym, zbierając wywiad dotyczący przyjmowania leków?
4. Opisz, na co zwrócisz uwagę, badając skórę u osób w wieku geriatrycznym.

Rozdział 16

1. Jaki schemat stosowany do opisu opieki pielęgniarskiej jest podobny do schematu SOAPIER? Uzasadnij swoją odpowiedź.
2. 45-letnia kobieta została przyjęta do kliniki z powodu bólu brzucha. Twierdzi, że ból rozpoczął się 2 dni temu, zlokalizowany jest wewnątrz ciała, w żołądku, ma charakter stały, promieniujący do prawego dolnego kwadrantu, nasila się wraz z aktywnością ruchową. Ocenia ból na 8/10 w skali VAS. Jaką część opisu stanu zdrowia pacjenta według schematu SOAP możesz uzupełnić, wykorzystując powyższe informacje?
3. Wymień co najmniej trzy korzyści wynikające ze stosowania klinimetrii w praktyce pielęgniarskiej.
4. Określ co najmniej trzy działania, które należy wykonać, zanim uzyskasz ocenę bólu u dziecka.
5. Napisz, jakich zasad dokumentowana przestrzegasz w swojej praktyce pielęgniarskiej (co najmniej 5).

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

Rozdział 1

1. Tożsamość kulturowa to względnie trwała identyfikacja grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określoną kulturą rozumianą jako zbiór wyuczonych, podzielanych i przekazywanych w danej grupie społecznej wartości, wierzeń, norm, zachowań, które narzucają sposób myślenia, podejmowania decyzji i działania jej członków.

2. Aby rozwijać własną wrażliwość kulturową, pielęgniarka powinna:

- dostrzegać różnorodność kulturową ludzi,
- okazywać szacunek dla człowieka jako niepowtarzalnej biopsychospołecznej indywidualności uwarunkowanej kulturowo,
- szanować nieznane,
- poznawać i analizować własne przekonania kulturowe,
- akceptować odmienne niż swoje własne podejście do spraw zdrowia i choroby przez pacjenta w granicach obowiązującego prawa,
- modyfikować opiekę pielęgniarską tak, aby uwzględnić potrzeby kulturowe pacjenta,
- przyjąć, że wartości i przekonania kulturowe człowieka są zinternalizowane i bardzo trudno je zmienić.

3. Podczas oceny stanu zdrowia pacjenta należy uwzględnić uwarunkowania kulturowe wynikające z:

- roli rodziny w danej grupie kulturowej (więzi rodzinne, autorytety w rodzinie, podejmowanie decyzji w rodzinie, tradycje rodzinne, role pełnione w rodzinie),
- wyznawanej religii (dieta i wzorce żywieniowe, zasady utrzymania higieny ciała, przekonania dotyczące kwestii zdrowia, choroby, cierpienia i śmierci),
- preferowanych sposobów komunikacji,
- wartości, wierzeń, norm i zachowań obowiązujących w danej kulturze (definiowanie pojęcia „zdrowie", „choroba", akceptowanie metod medycyny niekonwencjonalnej, wynikające z tego zachowania zdrowotne, styl życia, postawy wobec śmierci i umierania).

Rozdział 2

1. W czasie badania podmiotowego należy:

- zadbać, aby miejsce, w którym odbywać się będzie badanie, nie powodowało skrępowania i dyskomfortu pacjenta,
- wziąć pod uwagę harmonogram dnia pacjenta,
- na początku się przedstawić i poinformować pacjenta o planowanych wobec niego działaniach,
- siedzieć naprzeciw pacjenta, utrzymywać z nim kontakt wzrokowy, stosować proste gesty,
- rozpoczynać wywiad od spraw ogólnych, a następnie kolejno skupić się na aktualnych dolegliwościach,
- nie pytać pacjenta o kilka rzeczy w jednym momencie,
- wykorzystywać zasady kontaktu terapeutycznego, nie zapominać o zwrotach, które wyrażają empatię.

2. Sytuacje, które utrudniają wywiad lub powodują, że jest on specyficzny dla danej grupy pacjentów:

- Wiek badanego pacjenta (dzieci i osoby starsze) – wywiad w tych dwóch grupach wiekowych staje się specyficzny.
- Upośledzenie pamięci u pacjentów starszych, ale również tych z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi na skutek urazu lub organicznej choroby mózgu.
- Pacjent milczący, gadatliwy, lękowy – to grupa, w której każdy z pacjentów będzie się skupiał w pewien sposób na sobie i często będzie miał trudności z nazwaniem dolegliwości.
- Pacjent uzależniony od narkotyków lub alkoholu – efekty rozmowy zależą od tego, czy odbywa się ona w czasie, kiedy pacjent jest odurzony lub w stanie upojenia alkoholowego.
- Pacjent z deficytami neurologicznymi – to pacjent, który często nie rozumie zadawanych pytań lub nie może powiedzieć o swoich dolegliwościach pomimo ich rozumienia.
- Rodzina i przyjaciele – zdarza się, że nie pozwalają pacjentowi samodzielnie powiedzieć o swoich objawach chorobowych, o tym, co odczuwa lub jak zapatruje się na proponowane możliwości postępowania leczniczego, pielęgnacyjnego czy rehabilitacyjnego.
- Chorzy nieprzytomni – często źródłem informacji o nich są świadkowie zdarzenia w miejscu zamieszkania chorego lub w miejscu publicznym. Czasami ma się do czynienia z nadmiarem informacji, niespójnych, chaotycznie przekazywanych i trzeba wysondować te, które pozwolą poznać przyczynę stanu pacjenta.

- Chorzy w stanie terminalnym – prowadzenie wywiadu wymaga od badającego postawy empatii i zrozumienia dla decyzji i woli pacjenta.

3. Badanie podmiotowe oparte na schemacie Calgary–Cambridge składa się z pięciu głównych punktów:

- Początek wywiadu – nawiązanie z badanym kontaktu i podjęcie próby określenia problemu.
- Gromadzenie informacji, omówienie problemów chorego oraz poznanie i zrozumienie zapatrywania chorego na jego własny problem oraz dokonanie systematycznego pogrupowania uzyskanych danych.
- Zbudowanie zaufania między badanym i badającym dzięki uzyskaniu zwrotnej informacji od pacjenta oraz postawienie na jego zaktywizowanie.
- Przekazanie pacjentowi niezbędnych informacji dotyczących jego sytuacji zdrowotnej. Pomoc w zrozumieniu i odnalezieniu się w tej sytuacji oraz zaplanowanie z nim przebiegu dalszego postępowania z uwzględnieniem jego decyzji, oczekiwań i postawy.
- Zakończenie spotkania z pacjentem.

4. Porządek zadawania pytań według OLDCART:

O – kiedy rozpoczęły się dolegliwości?
L – gdzie są odczuwane dolegliwości?
D – jak długo pacjent odczuwa daną dolegliwość?
C – jak może opisać, scharakteryzować swoje dolegliwości?
A – jakie są czynniki, które pogarszają dany objaw/objawy?
R – jakie są czynniki, które łagodzą dolegliwości?
T – jakie leczenie dotychczas zastosowano?

Rozdział 3

1. Ciało jest w pozycji stojącej, wyprostowane, stopy złączone na podłożu, ramiona wyprostowane, powierzchnie dłoniowe rąk skierowane do przodu, a kciuki – na zewnątrz.

2. Badanie przedmiotowe z wykorzystaniem metody opukiwania pozwala uzyskać np. informacje o granicach narządów wewnętrznych, obecności w jamach ciała płynu albo gazu i wielkości innych zmian. Miejsca opukiwane różnicuje się na podstawie odgłosu opukowego, którego charakter zależy od ilości powietrza znajdującego się w opukiwanym miejscu.

3. Stan odżywienia ocenia się na podstawie m.in. wartości takich parametrów, jak: masa ciała, grubość fałdu skórno-tłuszczowego, obwód ramienia.

4. Niewłaściwie dobrany mankiet może powodować zafałszowanie wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi: za szeroki będzie powodował zawyżenie wartości ciśnienia, za wąski – zmniejszenie jego wartości. Szerokość mankietu ciśnieniomierza powinna stanowić 40% obwodu ramienia. Standardowo wynosi 12–14 cm.

Rozdział 4

1. Metodą palpacyjną (obmacywaniem) ocenia się:
   - ciepłotę skóry,
   - wilgotność skóry,
   - napięcie i elastyczność skóry,
   - ruchomość skóry – łatwość przesuwania się fałdu skórnego (zmniejszona jest w przypadku obrzęku).
2. Odróżnia się włosy długie, krótkie i meszek włosowy. Włosy mogą być rzadkie, gęste, delikatne, a w przypadku włosów brwi i rzęs grube i twarde (szczotkowate). U osób dorosłych włosy wyrastają na całej powierzchni skóry z wyjątkiem dłoni, podeszew i bocznych powierzchni palców. Prawidłowo powinny być rozmieszczone w obrębie głowy, brwi, powiek, brody, okolic pachowych, na tułowiu, w okolicach narządów płciowych oraz na kończynach.
3. Prawidłowa płytka paznokciowa ma kolor różowy, jest gładka, dość dobrze uwypuklona poprzecznie – kąt między płaszczyzną płytki paznokciowej a płaszczyzną palca jest mniejszy niż 180°. Zmiany chorobowe paznokci: kształt łuseczkowaty – wgłębienie płytki paznokci – w niedokrwistości; brak paznokci – zaburzenia krążenia obwodowego; zanokcica – ostry lub przewlekły stan zapalny bliższego i bocznych obrąbków paznokciowych.
4. Wielkość prawidłowych węzłów chłonnych waha się od 2–4 do 10 mm. Zwykle nie są one wyczuwalne dotykiem, są niebolesne i niewrażliwe na ucisk.
5. Naczynia chłonne ręki, przedramienia i ramienia odprowadzają chłonkę do węzłów chłonnych ponad kłykciem przyśrodkowym kości ramiennej, pachowych i podobojczykowych. Węzeł chłonny ponad kłykciem przyśrodkowym kości ramiennej jest najdalej położonym węzłem chłonnym ramienia. Naczynia chłonne kończyn dolnych odprowadzają chłonkę do węzłów podkolanowych, następnie do grupy węzłów pachwinowych.

   Badanie obwodowych węzłów chłonnych obejmuje oglądanie i obmacywanie:
   - Podczas oglądania ocenia się umiejscowienie i wielkość węzłów chłonnych oraz wygląd skóry nad nimi.